

Guía para la
Operación
de Mama



Fred Hutch
Cancer Center

Índice

Introducción	4
Programa y lista de verificación para la operación	5
Preparación para la operación	7
Sobre su experiencia con la operación.	7
Medicamentos que debe evitar antes de la operación	19
Planificación de la atención médica con antelación	22
Tipos de operación de mama	23
Tumorectomía.	23
Estiramientos y ejercicios: Después de la tumorectomía o biopsia del nódulo linfático centinela (SLNB)	26
Mastectomía	33
Cuidado del drenaje	36
Estiramientos y ejercicios: Después de su mastectomía o disección de ganglios linfáticos axilares (ALND) con o sin LYMPHA	42
Atención después de la operación	49
Administración de los medicamentos de apoyo.	49
Estreñimiento después de la operación	50
Linfedema	54
Trombosis venosa profunda (TVP).	57
Prevención de caídas.	60
Cómo tomar fotos de su herida	62
Recursos	65
Centro de Recursos para Pacientes y Familias	65
Información para el paciente	65
Recursos para el cáncer de mama	66
MyChart.	68
Camisolas, sostenes y prótesis para después de la mastectomía	69
Lugares, direcciones y estacionamiento	71

Introducción

El compromiso de Fred Hutch Cancer Center es darle una experiencia segura con la operación. Como parte de ese compromiso, elaboramos esta guía. La información que incluye y una reunión con el equipo de atención lo ayudarán a saber qué esperar antes y después de la operación. Lea detenidamente estas páginas y comuníquese con el equipo de atención si tiene alguna duda.

Nombre: _____

Fecha de la operación: _____

Cirujano: _____

Fred Hutch es una organización independiente sin fines de lucro que también sirve como programa de cáncer para UW Medicine. Esta relación exclusiva permite una mejor coordinación de la atención con uno de los principales sistemas médicos integrados del mundo.

UW Medicine

1354 Aloha Street, Seattle, WA 98109

(206) 606-7222

Llamada sin costo: (855) 557-0555

FredHutch.org

Programa y lista de verificación para la operación

Este programa y lista de verificación repasa lo que puede esperar antes y justo después de la operación. Cada punto se explica detalladamente en las páginas que siguen.

1 semana antes de la operación

- ☐ Revise esta guía y todos los folletos que recibió.
- ☐ Siga las instrucciones del proveedor de atención médica sobre los medicamentos que debe dejar de tomar antes de la operación (vea la sección **Medicamentos que debe evitar antes de la operación** en esta guía).
- ☐ Si tiene programada una mastectomía, programe una prueba y recoja sus camisolas posoperatorias.
- ☐ **No** se afeite ninguna área cercana al lugar de la operación por 2 días (48 horas) antes de la operación.
- ☐ Recibirá una llamada 2 días antes de la operación para decirle cuándo debe registrarse el día de la operación.

1 día antes de la operación

- ☐ A menos que le hayan dado otras instrucciones sobre comidas y bebidas:
 - o Si su hora de llegada está programada **para las 6:30 a. m. o antes**, no coma nada ni beba alcohol **después de las 11 p. m.** la noche anterior a la operación.
 - o Si su hora de llegada está programada **después de las 6:30 a. m.**, no coma nada ni beba alcohol **después de la medianoche** anterior a la operación.
 - o **Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la hora de llegada programada** (vea la sección **Instrucciones sobre comidas y bebidas** en esta guía).

Si toma medicamentos agonistas del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) como dulaglutide (Trulicity®), semaglutide (Ozempic®, Rybelsus®), tirzepatide (Mounjaro®, Zepbound®) u otros para la diabetes o el control de peso, **hable con su equipo de atención lo antes posible porque necesitará instrucciones diferentes sobre comidas y bebidas.**

- ☐ Haga arreglos para que un adulto responsable lo lleve a su casa desde el hospital y para que alguien se quede con usted durante las primeras 24 horas después de la operación.
- ☐ La noche antes de la operación, tome su primera ducha prequirúrgica con el jabón que le entregaron en la cita en la clínica. **No** use el jabón en la cara, el pelo o los genitales. **No** use productos como perfumes/aceites, desodorantes/antitranspirantes, productos

1 día antes de la operación (continúa)

para el pelo, lociones, enjuague bucal o maquillaje. Tomará una segunda ducha la mañana de la operación. Vea la sección **Instrucciones para la ducha** de esta guía para obtener las instrucciones completas.

- ☐ Si tiene alguna pregunta sobre sus medicamentos o no ha recibido una llamada para informarle cuándo debe registrarse para su operación, llame a la **Clínica de Preanestesia (Pre-Anesthesia Clinic)** en **UW Medical Center – Montlake**: (206) 598-6334 o **UW Medical Center – Northwest**: (206) 668-1010.

El día de la operación

- ☐ Continúe siguiendo las instrucciones sobre comidas y bebidas para antes de la operación.
- ☐ Si necesita tomar algún medicamento la mañana de la operación, tómelo únicamente con un pequeño sorbo de agua.
- ☐ Tome su segunda ducha antes de la operación con el jabón que le entregaron en la cita en la clínica. Siga las mismas **instrucciones para la ducha** que siguió para su primera ducha.
- ☐ Quítese todas las joyas y piercings del cuerpo.
- ☐ Use ropa limpia, holgada y cómoda.
- ☐ Traiga su identificación con fotografía y su tarjeta del seguro.
- ☐ Traiga un método de pago para cualquier copago por medicamentos necesarios después de la operación. En ambos centros quirúrgicos se acepta dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
- ☐ Traiga una copia de sus directivas de atención médica o poder notarial duradero para atención médica para que puedan ponerse en su expediente médico.
- ☐ Si usa una máquina de CPAP por la noche para ayudarlo a respirar, tráigala con usted.
- ☐ Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto responsable en todo momento. No traiga menores sin supervisión.
- ☐ Regístrese para la operación en:
 - **Registro en UW Medical Center – Montlake: Surgery Pavilion Reception Center, 2.º piso**
 - **Registro en UW Medical Center – Northwest: Entrada norte/Ingreso de operación (Surgery Admitting)**

Después de la operación

- ☐ Un adulto responsable debe llevarlo a su casa desde el hospital y alguien debe quedarse con usted durante las primeras 24 horas.
- ☐ Si va a pasar la noche en el hospital, un familiar o amigo puede quedarse con usted.
- ☐ Para prevenir y manejar problemas frecuentes después de la operación, lea las secciones **Preparación para la operación** y **Atención después de la operación** en esta guía.

Preparación para la operación

Sobre su experiencia con la operación

La información en esta sección y la visita con el cirujano y el personal de la Clínica de Preanestesia lo ayudarán a prepararse para la operación de mama. Es importante que entienda lo que ocurrirá y por qué.

Información sobre el registro

Si la operación es un **día entre semana**, regístrese en:

- **UW Medical Center – Montlake Pavilion Surgery Center**

Surgery Pavilion, 2.º piso
1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195

- **UW Medical Center – Northwest**

North Entrance - Ingreso de operación (Surgery Admitting) (Estacionamiento F)
1550 N. 115th St., Seattle, WA 98133

Si la operación es un sábado, regístrese en:

- **UW Medical Center – Montlake, Ingreso**

3.er piso (lobby de la planta principal)
1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195

Si la operación está programada en UW Medical Center – Montlake

El personal de la Clínica de Preanestesia lo llamará 2 días hábiles antes de la operación, entre las 9 a. m. y las 3 p. m. Le dirán dónde debe registrarse, a qué hora debe llegar y qué debe llevar. Si no ha recibido esta llamada antes de las 3 p. m., llame al **(206) 598-6334**.

Si la operación está programada en UW Medical Center – Northwest

El personal del Departamento Prequirúrgico (Pre-Surgical Department) lo llamará 2 días hábiles antes de la operación para darle instrucciones, darle información y responder cualquier pregunta que pueda tener. Si no recibió esta llamada antes de las 3:00 p. m., llame al Departamento Prequirúrgico al **(206) 668-1010** de 9:00 a. m. a 6:30 p. m. de lunes a viernes.



Intérpretes

UW Medical Center has interpreters to help you, if needed, before and after surgery. Please tell the patient care coordinator or Pre-Anesthesia Clinic nurse if you would like an interpreter. Or, call Interpreter Services at **(206) 598-4425**.

UW Medical Center tiene intérpretes para ayudarlo antes y después de la operación, si lo necesita. Dígale al coordinador de atención al paciente o al enfermero de la Clínica de preanestesia que quiere un intérprete. O llame al Servicio de Intérpretes al **(206) 598-4425**

Reunión con el cirujano

Como primer paso, se reunirá con el cirujano en Fred Hutch. En esta reunión, el cirujano y otros proveedores de atención médica:

- Revisarán su historia médica y los medicamentos que toma en casa
- Le harán un examen físico
- Hablarán con usted sobre la operación
- Le pedirán que firme un formulario de consentimiento

Pregunte al cirujano cómo podría limitarse su actividad después de la operación y cuánto tiempo durarán estas limitaciones. Piense detenidamente sobre la ayuda que necesitará y organice esta ayuda antes de la operación. Tendrá que planificar cosas como la manera de ir al baño, subir y bajar las escaleras, preparar las comidas y cuidar de usted mismo.

Clínica de Preanestesia

Necesitamos información sobre su salud antes de la operación para conocer los problemas que pueden afectar su atención y recuperación.

La clínica de operación enviará su información médica a la Clínica de Preanestesia para revisión. Si necesita una cita con la Clínica de Preanestesia, le programarán una.

Qué debe traer a la Clínica de Preanestesia

- ☐ **Una lista de todos los medicamentos que toma y las dosis de cada uno.**
- ☐ **Los resultados de las pruebas que le hayan hecho en cualquier otro hospital o clínica,** especialmente las pruebas de diagnóstico del corazón o los pulmones, como un electrocardiograma (EKG), una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma o pruebas de función pulmonar. Incluiremos copias de estos registros en el paquete de información quirúrgica. Si necesita ayuda para obtener los resultados de las pruebas del médico o de la clínica, pregunte y lo ayudaremos.

Los proveedores expertos en anestesia revisarán la encuesta médica, la historia médica, la lista de medicamentos en casa y los resultados de las pruebas. Usted no conocerá al equipo de anestesia en esta visita. Los conocerá el día de la operación.

Medicamentos antes de la operación

Asegúrese de decirle al cirujano y al personal de la Clínica de Preanestesia qué medicamentos está tomando. Es posible que tenga que dejar de tomar algunos de ellos durante un día o más antes de la operación. Algunos de los medicamentos que puede tener que dejar de tomar son:

- Medicamentos orales para la diabetes e insulina
- Warfarin (Coumadin®)
- Clopidogrel (Plavix®)
- Aspirin y otros medicamentos que afectan la coagulación de sangre, como ibuprofen (Advil®, Motrin® y otros) y naproxen (Aleve®, Naprosyn® y otros)
- Ciertos medicamentos para bajar de peso
- Remedios y suplementos a base de hierbas

Un proveedor de preanestesia le dirá qué medicamentos puede tomar la mañana de la operación.

Anestesia

Un equipo de proveedores de anestesia estará con usted durante la operación para mantenerlo cómodo. También monitorearán la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión y cualquier cuestión médica que pueda surgir.

En la visita preanestésica, los proveedores pueden hablar con usted sobre la posibilidad de recibir 1 o más de estos tipos de anestesia:

- **Anestesia general:** Usted está inconsciente (dormido) y no tiene conciencia de la operación.
- **Anestesia regional:** Se inyecta un medicamento adormecedor en un grupo de nervios, de modo que no tiene sensación en una gran área del cuerpo. También le pueden dar un medicamento para relajarlo o ayudarlo a dormir.
- **Atención de anestesia monitoreada (MAC):** Los medicamentos MAC se administran por medio de una vena del brazo (por vía intravenosa). Es posible que reciba un sedante (medicamento para que se relaje), pero puede estar despierto durante el procedimiento. También le pueden administrar un anestésico local, que adormece el área en la que se hará el procedimiento. Con MAC, es posible que tenga sueño, esté muy somnoliento o que caiga en un sueño profundo.

Durante la visita preanestésica, dígame al proveedor si quiere hablar con un anestesista sobre cualquier preocupación especial.

Instrucciones sobre comidas y bebidas

A menos que tenga instrucciones del médico sobre la limpieza del intestino, el día y la noche antes de la operación:

- Coma normalmente.
- Tome sus medicamentos habituales (a menos que le indiquen que no).
- Siga las directrices de ayuno incluidas en esta sección.

Directrices de ayuno

Siga estas directrices sobre no comer ni beber antes de la operación. Estas directrices reducen el riesgo de vomitar e inhalar el contenido del estómago hacia los pulmones durante la operación.

Debe seguir estas directrices de ayuno. Por su seguridad, si no sigue estas directrices de ayuno, es posible que sea necesario reprogramar la operación para otro día.

Algunos pacientes pueden beber líquidos después de la medianoche anterior a la operación. Esto está basado en el tipo de operación que tenga. Su proveedor le explicará las directrices que debe seguir.

Para todos los pacientes:

A menos que reciba otras instrucciones:

- Si su hora de llegada está programada **para las 6:30 a. m. o antes**, no coma nada ni beba alcohol **después de las 11 p. m.** la noche anterior a la operación.
- Si su hora de llegada está programada **después de las 6:30 a. m.**, no coma nada ni beba alcohol **después de la medianoche** anterior a la operación.
- Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la hora de llegada programada. Esto incluye agua, jugos claros (sin pulpa), bebidas carbonatadas, té claro o café (sin sustitutos de crema no lácteos ni leche).
 - Si necesita tomar un medicamento después de que le hayan dicho que deje de comer o beber, tómelo sin más de 2 onzas (4 cucharadas) de agua.

Si toma medicamentos agonistas del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) como dulaglutide (Trulicity®), semaglutide (Ozempic®, Rybelsus®), tirzepatide (Mounjaro®, Zepbound®) u otros para la diabetes o el control de peso, **hable con su equipo de atención lo antes posible porque necesitará instrucciones diferentes sobre comidas y bebidas.**

Instrucciones para la ducha

Use un jabón especial llamado **gluconato de clorhexidina** (CHG) para ducharse o bañarse dos veces, **tanto la noche anterior como la mañana de la operación**. Si no recibió un frasco de CHG en la cita clínica preoperatoria o lo olvidó en su cita clínica preoperatoria, puede comprar CHG en la mayoría de las farmacias grandes. Puede usar una solución al 2 % o al 4 %. Una marca frecuente es *Hibiclens*®, pero puede usar cualquier marca.

Para las duchas la noche anterior y la mañana de la operación:

1. Si quiere lavarse la cara y el pelo, hágalo primero usando el jabón y champú habituales. **No** use CHG en la cara, el pelo ni en los genitales.
2. Después de lavarse la cara y el pelo, aléjese de la ducha o cierre el grifo.
3. Use una toallita húmeda para aplicarse una gran cantidad de jabón CHG desde el cuello hasta los pies. Agregue más jabón según sea necesario para que todo el cuerpo quede limpio, especialmente la parte del cuerpo donde se hará la operación.
4. Deje el jabón en la piel durante 1 minuto completo. Después de 1 minuto, vuelva a abrir la ducha y enjuague bien.
5. Seque sin frotar con una toalla **limpia**. Póngase ropa **limpia**.
6. Después de la ducha o el baño de la noche y de la mañana de la operación, no use productos como perfumes/aceites, desodorante/antitranspirante, para el cuidado del pelo, lociones, enjuagues bucales ni maquillaje.

Afeitado

Para reducir el riesgo de infecciones:

- No se afeite ninguna parte del cuerpo que no se haya afeitado 7 días antes de la operación.
- No se afeite ninguna área que normalmente se afeite 2 días antes de la operación.

Llegada al hospital

Cuando venga para la operación:

- Siga las instrucciones para la ducha como se indicó antes y **no** use productos como perfumes/aceites, desodorante/antitranspirante, para el cuidado del pelo, lociones, enjuagues bucales ni maquillaje.
- Use ropa holgada que sea fácil de quitar y cómoda para llevar a casa.

Llegada al hospital, continuación

- No traiga objetos de valor.
- Quítese todas las joyas y piercings.

Qué debe traer al hospital

- ☐ Una lista de sus medicamentos y las dosis de cada uno. No traiga los medicamentos en sí, a menos que se lo indiquen.
- ☐ Una identificación con fotografía, sus tarjetas del seguro médico y de farmacia, y un método de pago (copago) para cualquier medicamento para el alta que pueda necesitar.
- ☐ Una copia de sus directivas de atención médica o poder notarial duradero para atención médica para que puedan ponerse en su expediente médico.
- ☐ Su número de reclamo de L&I, si tiene uno.
- ☐ Su máquina de CPAP si tiene apnea del sueño y la usa por la noche para ayudarlo a respirar.
- ☐ Un libro, una tablet o un pequeño proyecto, como material para tejer o Sudoku, para usar mientras espera que comience la operación.

Registrarse

Generalmente, le pedimos que se presente entre 1½ y 2 horas antes de la operación. Esto nos da tiempo para prepararlo para la operación. Durante este tiempo:

- Firmará los formularios de ingreso.
- Revisaremos cualquier cambio en su salud.
- Le informaremos sobre cualquier cambio que pueda afectar la hora de inicio de la operación.

Preparación para la operación

Muchos pacientes estarán preparándose en el área de “preparación” de la operación.

En un espacio privado, le pediremos que se quite la ropa, incluyendo la ropa interior. Se pondrá una bata de hospital. Deberá quitarse los anteojos, los lentes de contacto y el aparato auditivo. Posiblemente le pidan que se quite la dentadura postiza si la lleva. Traiga estuches para guardar estos objetos si los tiene.

Preparación para la operación (continúa)

Los enfermeros, el equipo quirúrgico y el equipo de anestesia pasarán por su habitación para reunirse con usted antes de la operación. Podrá hacerles cualquier pregunta que tenga sobre su atención.

Para reducir el riesgo de infección, cubrirán la parte inferior de su cuerpo con una manta térmica para mantenerlo caliente mientras espera entrar a la sala de operaciones. Pida una manta térmica si no la recibe.

El cuidador o persona de apoyo

El cuidador adulto o una persona de apoyo puede estar con usted durante el tiempo de “preparación”. Usted o el equipo de atención puede pedirle que salga del espacio de preparación, si es necesario.

El cuidador o persona de apoyo puede esperar en la sala de espera cuando a usted lo lleven a la operación. Es posible que él quiera traer algo para leer mientras espera, una computadora portátil u otro dispositivo electrónico. Hay acceso a Internet inalámbrico disponible en la mayoría de las áreas del hospital.

El hospital no puede dar cuidado infantil. Si tiene que traer a un niño menor de 17 años al hospital, pida que un adulto responsable lo acompañe en todo momento.

Identificación y marcado del lugar de la operación

Tenemos el compromiso de asegurar que reciba una atención segura y de alta calidad. Mientras esté aquí, a usted o a su familia le harán preguntas como:

- ¿Cuál es su nombre?
- ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
- ¿Qué operación se va a hacer?

No se alarme por estas preguntas. Sabemos quién es usted. Hacemos algunas o todas estas preguntas repetidamente por su seguridad.

El médico revisará el expediente médico y hablará con usted o con un familiar para confirmar el lugar de la operación o procedimiento. La mayoría de las veces, cuando tiene una operación o un procedimiento, el médico marcará el lugar con un bolígrafo para ayudar a mantener su seguridad. Si es necesario marcar el lugar de la operación, el cirujano lo marcará con sus iniciales. Se tendrá cuidado especial si tiene una operación o procedimiento en el lado derecho o izquierdo del cuerpo. **No marque ni escriba nada en su cuerpo.** Si no es necesario marcar el lugar, le pediremos que confirme qué operación o procedimiento tendrá.

Inicio de la vía intravenosa

Antes de que comience la operación le pondremos una vía intravenosa (IV). La vía intravenosa es una pequeña aguja y un tubo delgado que se usa para administrarle medicamentos y líquidos durante la operación. También es posible que le administren un medicamento por vía intravenosa para ayudarlo a relajarse antes de la operación. La mayoría de las veces, esto se hace en la parte superior de la mano o del brazo. Primero le pondremos un anestésico en la piel, en el lugar donde se pondrá la vía intravenosa.

Pacientes femeninas

Es posible que reciba información sobre una prueba de embarazo en orina antes de la operación. Dígale al enfermero o a un miembro del personal de anestesia si quiere hacerse la prueba.

Después de la operación

Lo llevarán a la sala de recuperación después de la operación. La sala de recuperación también se llama Unidad de Cuidados Posanestésicos (Post-Anesthesia Care Unit, PACU). La mayoría de los pacientes permanecen en la sala de recuperación entre 1 y 2 horas después de la operación.

Visitas

La mayoría de las veces, sus seres queridos podrán visitarlo en PACU, si así lo quiere. Esto será después de que reciba la atención que necesita para garantizar su seguridad mientras se despierta de la anestesia y se trata el dolor, si es necesario. El espacio en el área de PACU es limitado, por lo que solo podrá tener la visita de 1 adulto a la vez.

Supervisión

Un enfermero controlará la respiración, frecuencia cardíaca y presión con frecuencia. El enfermero lo ayudará con las náuseas o el dolor que pueda sentir. Es importante que esté cómodo.

Control del dolor

Asegúrese de pedirle al enfermero un analgésico antes de que el dolor sea demasiado intenso. El enfermero le pedirá que califique el dolor en una escala de 0 a 10, donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor. Puede recibir los analgésicos por:

- Boca (píldoras, cápsulas o líquido)
- Medicamento por vía intravenosa

Control del dolor, continuación

Si pasa la noche en el hospital, también puede recibir:

- Analgésicos administrados por medio de un pequeño tubo en la espalda (epidural).
- Analgesia controlada por el paciente (PCA). La máquina PCA introduce una dosis de analgésico en la vía intravenosa cuando **usted** presiona el botón. Con PCA, usted no tiene que esperar a un enfermero. Usted tiene el control de los analgésicos. Sus médicos le recetarán la cantidad adecuada de medicamento. **No** se volverá adicto a estos medicamentos si usa PCA según las instrucciones.

ADVERTENCIA: Por su seguridad, **solo usted** debe presionar el botón de PCA.

NO deje que las visitas presionen el botón de PCA.

Alta el mismo día de la operación

Si se le da el alta del hospital el mismo día de la operación y recibió sedación o anestesia:

- Debe **haber** un adulto responsable que lo acompañe a casa o al lugar donde se quedará mientras se recupera de la operación.
- Usted **no puede** conducir.
- No **puede** tomar un taxi, Hopelink o un autobús usted solo.

Si no consiguió que un adulto o un transporte aprobado (como Cabulance) lo acompañe cuando lo den el alta del hospital, podemos cancelar su operación. Su acompañante debe ayudarlo a llegar a casa o al lugar de recuperación y ayudarlo a instalarse.

Las primeras 24 horas

A partir del momento del alta y hasta un mínimo de 24 horas después, debe estar con usted un adulto responsable que lo ayude con las actividades diarias. Este adulto debe poder ayudar con la atención en casa o en el lugar de recuperación. Esto es por su seguridad, en caso de que tenga algún problema y necesite más atención después de la operación. **Si decide no seguir este requisito, UW Medical Center no se hace responsable.**

- Es posible que tenga un poco de dolor y náuseas después de la operación. También es posible que esté somnoliento el resto del día.

Las primeras 24 horas, continuación

- Durante 24 horas después de la anestesia, **no**:
 - Conduzca.
 - Beba alcohol.
 - Viaje solo.
 - Use maquinaria.
 - Firme ningún documento legal.
 - Cuide de otra persona, como por ejemplo un menor.
- Antes de salir del hospital, le daremos:
 - Información sobre la atención en casa.
 - Un teléfono para programar la visita de seguimiento, si esta cita no está ya programada.

Si pasa la noche en el hospital después de la operación

- Es posible que tenga que usar una bata de hospital.
- Haremos todo lo posible para proteger su intimidad y mantener su seguridad. Su seguridad es nuestra prioridad.
- Para evitar que se caiga, podemos usar:
 - Una alarma que nos avise cuando se levante de la cama.
 - Alfombras en el piso cerca de la cama.
 - Un cinturón alrededor de la cintura cuando se levante de la cama y cuando camine.
 - Un miembro del personal que permanezca cerca de usted cuando use el baño o un inodoro portátil.
- La capacidad para hacer cosas usted solo puede cambiar día a día. Esto significa que también es posible que tengamos que cambiar las cosas que hacemos para mantenerlo seguro.
- Es posible que esté conectado a tubos y máquinas.
- El personal revisará cómo se siente muchas veces al día.
- Posiblemente le pongan vendas que le aprieten la parte inferior de las piernas mientras está en la cama. Estas vendas, llamadas *dispositivos de compresión secuencial* (SCD), ayudan a prevenir los coágulos de sangre.

Riesgo de caídas

Mientras está en el hospital, el riesgo de caídas es mayor. Esto se debe a que:

- Está en un lugar nuevo.
- Puede estar débil y cansado por los cambios de salud o enfermedad.
- Puede sentirse mareado, aturdido o confundido después de la operación o a causa de la enfermedad.
- Algunos medicamentos pueden afectar su capacidad para pensar con claridad.
- Algunos medicamentos pueden provocar una necesidad urgente de orinar (hacer pipí).
- Los hábitos para ir al baño son diferentes en el hospital y en casa.
- Algunos medicamentos pueden afectar su fuerza muscular.
- Posiblemente tenga las piernas hinchadas.
- Posiblemente se mueva más despacio o arrastre los pies después de la operación.
- Probablemente no duerma bien fuera de casa.
- Los tubos y las máquinas pueden impedir que se mueva con facilidad.

Pregunte al equipo de atención si tiene alguna duda o preocupación sobre cómo lo ayudamos a evitar las caídas durante su estancia en el hospital.

Medicamentos que debe evitar antes de la operación

Resumen

Esta sección menciona los medicamentos y suplementos específicos que debe evitar antes de la operación. Antes de la operación, asegúrese de revisar con el médico todos los medicamentos y suplementos que está tomando.

Preparación para la operación

Para evitar problemas de sangrado, es posible que el médico le pida que deje de tomar algunos medicamentos con receta, de venta libre y a base de hierbas antes de la operación.

Hable con el médico antes de dejar de tomar estos medicamentos antiplaquetarios con receta que se usan para prevenir los coágulos de sangre, un ataque cardíaco o un derrame cerebral:

- Aspirin
- Clopidogrel (Plavix®)
- Dipyridamole (Persantine®)
- Dipyridamole/aspirin (Aggrenox®)
- Prasugrel (Effluent®)
- Ticagrelor (Brilinta®)

Estos medicamentos anticoagulantes con receta necesitan instrucciones especiales antes de que los suspenda o vuelva a tomarlos. Pida instrucciones al médico o a la Clínica de Anticoagulación (Anticoagulation Clinic).

- Apixaban (Eliquis®)
- Dabigatran (Pradaxa®)
- Dalteparin (Fragmin®)
- Edoxaban (Savaysa®)
- Enoxaparin (Lovenox®)
- Fondaparinux (Arixtra®)
- Rivaroxaban (Xarelto®)
- Warfarin (Coumadin®)

Evite los productos mencionados en esta sección

Debe evitar los productos mencionados en esta sección los días antes y después de la operación. Aquí tiene las instrucciones específicas del médico:

- Deje de tomar los productos mencionados en esta sección _____ días antes de la operación.
- Puede volver a tomar estos productos _____ días después de la operación.
- Puede tomar acetaminophen (Tylenol®) según sea necesario para dolores menores.
- Puede tomar medicamentos como ibuprofen si se lo indica el equipo quirúrgico.

Tenga en cuenta que las listas de esta sección no están completas. Otros productos o suplementos también pueden causar problemas de sangrado. Consulte con el médico si tiene dudas sobre productos específicos.

• Medicamentos analgésicos con receta que contienen aspirin u otros salicylates:

- Ascomp con codeine
- Lanorinal
- Productos de Soma
- Compuesto de Carisoprodol
- Productos con Percodan
- Productos con Trisalicylate
- Empirin con codeine
- Salsalate (Disalcid)
- Zorprin
- Fiorinal

• Medicamentos analgésicos con receta que contienen agentes antiinflamatorios no esteroideos:

- Diclofenac (Voltaren, Cataflam)
- Ketoprofen (Orudis, Oruvail)
- Nabumetone (Relafen)
- Etodolac (Lodine)
- Ketorolac (Toradol)
- Naproxen (Naprosyn, Anaprox)
- Fenoprofen (Nalfon)
- Meclofenamate (Meclomen)
- Oxaprozin (Daypro)
- Flurbiprofen (Ansaid)
- Mefenamic acid (Ponstel)
- Piroxicam (Feldene)
- Ibuprofen (Motrin)
- Meloxicam (Mobic)
- Sulindac (Clinoril)
- Indomethacin (Indocin)
- Tolmetin (Tolectin)

• Otros medicamentos analgésicos con receta:

- Celecoxib (Celebrex)
- Valdecoxib (Bextra)

Evite los productos mencionados en esta sección, continuación

● **Productos sin receta que contienen aspirin o salicylate:**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| ○ Productos de Alka-Seltzer | ○ Durlaza | ○ Miniprin |
| ○ Anacin | ○ Ecotrin | ○ Pain-off |
| ○ Productos de Bayer | ○ Ecpirin | ○ Pepto-Bismol |
| ○ Buffasal | ○ Empirin | ○ Saleto |
| ○ Bufferin | ○ Productos de Excedrin | ○ St. Joseph Adult |
| ○ Buffinol | ○ Femaprin (Fem-prin) | ○ Vanquish |
| ○ Doan's | ○ Halfprin | |

● **Productos sin receta que contienen medicamentos antiinflamatorios no esteroideos**

- | | | |
|------------------------|------------|--|
| ○ Productos de Advil | ○ Motrin | ○ Productos con ibuprofen (a menos que se lo indique el equipo quirúrgico) |
| ○ Productos de Aleve | ○ Naproxen | |
| ○ Midol Extra Strength | | |

● **Productos a base de hierbas y otros suplementos naturales:**

7 días antes de la operación, deje de tomar **todos**:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ○ Productos a base de hierbas | ○ Otros suplementos |
| ○ Suplementos naturales | ○ Vitaminas |

Podrá volver a tomar productos herbales y otros suplementos naturales cuando el médico lo autorice.

Adaptado con permiso de "Medicines to Avoid Before Surgery", ©2019, University of Washington Medical Center, Seattle, WA.

Planificación de la atención médica con antelación

Una enfermedad grave o un accidente puede ocurrirle a cualquiera a cualquier edad. La Planificación de la atención médica con antelación puede ayudarlo a documentar las decisiones sobre su atención médica en caso de que se enferme o lesione y ya no pueda hablar. Completar sus directivas anticipadas es una de las mejores maneras de asegurar que su familia, amigos y médicos conozcan sus decisiones de atención médica y las sigan.

Las directivas anticipadas son una combinación de dos documentos legales llamados:

- **Poder notarial duradero para la atención médica (DPOAHC):** Este formulario le permite nombrar a un agente de atención médica. El agente de atención médica es alguien que puede tomar decisiones sobre su atención, incluyendo las decisiones sobre el soporte vital, si ya no puede hablar por usted mismo. Si no designa al agente de atención médica, la ley de Washington le asignará uno.
- **Directiva de atención médica:** Este formulario expresa por escrito sus deseos sobre la atención médica, incluyendo las decisiones sobre el soporte vital si no puede hablar por usted mismo; por ejemplo, si está en coma. Tener instrucciones por escrito puede ayudar a reducir la confusión o el desacuerdo entre los familiares o los proveedores de atención médica. Su familia y los médicos están obligados por ley a seguir las instrucciones de la directiva de atención médica.

Puede completar solo DPOAHC o la combinación de la Directiva de atención médica/ DPOAHC. El formulario combinado necesita más tiempo para completarse, ya que le permite nombrar al agente de atención médica y describir el tratamiento que quisiera si tuviera un accidente o enfermedad grave y no pudiera hablar por usted mismo.

Una vez complete los formularios que quiere, entregue fotocopias del original firmado a los agentes de atención médica, médicos, abogado, familiares, amigos cercanos, clérigos y cualquier otra persona que pueda participar en su atención médica.

Para su comodidad, Fred Hutch proporciona documentos de planificación de la atención médica con antelación y una certificación notarial gratuita en el Centro de Recursos para Pacientes y Familias, situado en el 3.er piso de la Fred Hutch Sloan Clinic 1.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar los documentos para la Planificación de la atención médica con antelación, llame a Servicios de Atención de Apoyo (Supportive Care Services) de Fred Hutch al (206) 606-1076.

Tipos de operación de mama

Tumorectomía

La tumorectomía es una operación que implica extirpar el cáncer u otro tejido anormal de la mama manteniendo el aspecto de esta. Esta operación también puede llamarse operación de conservación de la mama, mastectomía parcial o biopsia por escisión.

Antes del procedimiento

Lea atentamente la sección “Sobre la experiencia con la operación” en esta guía y siga las instrucciones que se dan.

Localización del área a extirpar

Si la lesión que hay que extirpar se puede ver mediante mamografía o ultrasonido, pero no se puede palpar en la exploración física, nuestro Departamento de Imagenología de Mama dispone de dos maneras de marcar la lesión y ayudar a guiar al cirujano.

- **Localización guiada con alambre:** La mañana de la operación, usted vendrá a Fred Hutch Breast Imaging, antes de ir al hospital para la operación. Con una mamografía o ultrasonido, un radiólogo localizará el tumor en la mama. Luego, le adormecerán la piel y la mama y le insertarán un alambre delgado en la mama. El alambre delgado es una guía que ayuda al cirujano a encontrar y extirpar el tumor durante la operación. En algunos casos, se pondrá más de un alambre para marcar con precisión el área que hay que extirpar. Una vez completado el procedimiento de localización con alambre, el personal de Imagenología de Mama cubrirá y asegurará el alambre con una gasa. Luego, irá directamente al hospital para registrarse.
- **Localización con radar Scout:** Uno a varios días antes de la operación, usted vendrá a Fred Hutch Breast Imaging para que le pongan un pequeño dispositivo llamado reflector en el lugar donde está el tumor. Primero, el radiólogo confirmará el lugar donde está el tumor, adormecerá la piel y la mama, y luego, usará una pequeña aguja para poner el reflector. Una vez colocado, no debería sentir el reflector y podrá reanudar sus actividades normales. En la sala de operaciones, el cirujano usa un sistema que usa ondas de radar (seguras y no radiactivas) para detectar el lugar donde está el reflector en la mama. Tanto el tumor como el reflector se quitan durante la operación.

Extirpación de los nódulos linfáticos

En algunos casos, es necesario extirpar los nódulos linfáticos debajo del brazo para determinar si el cáncer se propagó. Hay dos opciones habituales de extirpación:

- **Biopsia del nódulo linfático centinela:** Los nódulos centinela son los nódulos linfáticos situados más cerca del cáncer y son los primeros en drenar la linfa de la mama. Estos nódulos, situados en la axila, son también los primeros a los que podría propagarse el cáncer. Cada persona tiene un promedio de 2 a 3 nódulos centinela. Los nódulos linfáticos extirpados se examinarán minuciosamente en busca de células cancerosas. Durante la operación, el cirujano le inyectará una pequeña cantidad de material radiactivo (también llamado radiotrazador) y un colorante azul debajo del pezón.

El material radiactivo y el colorante azul viajarán por sus vasos linfáticos hasta los nódulos linfáticos centinela. Con un equipo especial, el cirujano localizará y extirpará los nódulos que contienen el material radiactivo y que estén coloreados de azul. El tinte decolorará temporalmente la piel y la orina durante unas 24 horas.

- **Disección de los nódulos linfáticos axilares:** Este procedimiento implica extirpar la mayor parte o la totalidad de los nódulos linfáticos que están debajo del brazo. El cirujano puede recomendar este procedimiento si una biopsia de los nódulos linfáticos muestra que el cáncer se propagó.

Durante el procedimiento

Si le hacen una tumorectomía y cualquier operación de nódulos linfáticos, se las harán con anestesia general. Estará dormido y sin conocimiento durante el procedimiento. El cirujano hará una incisión para extirpar el tumor y otra para extirpar los nódulos linfáticos. Estas incisiones se cerrarán con puntos de sutura que se disuelven solos o con pegamento para la piel.

Si le hacen una disección de los nódulos linfáticos axilares, también le pondrán un drenaje debajo del brazo. Le enseñarán a usar el drenaje en casa antes de salir del hospital.

Después del procedimiento

- Es posible que el vendaje esté compuesto por Steri-Strips (cinta médica que cubre la incisión) o pegamento para la piel, cubierto por una tira de venda blanca y un vendaje adhesivo transparente. El vendaje adhesivo transparente y la tira de vendaje se deben quitar (en casa) 48 horas después de la operación. Deje las Steri-Strips o el pegamento para la piel hasta que se caigan solos (aproximadamente 1 a 2 semanas) o se las pueden quitar en Fred Hutch.
- En el momento de la operación se puede poner un sostén quirúrgico de apoyo, con más vendajes blandos. Este sostén se puede usar tanto de día como de noche si le resulta cómodo. Puede cambiar a su propio sostén de apoyo cuando se sienta preparado para ello.
- Lo enviarán a casa del hospital el mismo día o en un plazo de 24 horas después de la operación, dependiendo del procedimiento de nódulos linfáticos que se haga.
- Si le pusieron un drenaje debajo del brazo durante el procedimiento, le enseñarán a usarlo en casa antes de que deje el hospital. Consulte la sección “Cuidado del drenaje” en esta guía para obtener más información sobre el cuidado del drenaje después de la operación.
- Puede pasar a la farmacia del hospital antes de salir para recoger una receta de analgésicos.
- Puede ducharse en cualquier momento después de la operación, incluso el primer día.
- Puede estar tan activo como le resulte cómodo. Permita que el dolor sea su guía. Deje de hacer cualquier actividad que le cause malestar.
- Reanude su dieta habitual después de la operación. Intente prevenir el estreñimiento aumentando los líquidos y la fibra en la dieta. Consulte la sección “Estreñimiento después de la operación” en esta guía para obtener más información de cómo prevenir este problema habitual.
- Siga tomando los medicamentos habituales según se lo recetaron después de la operación.
- Le programarán que regrese a la clínica para la cita posoperatoria aproximadamente entre 7 y 14 días después de la operación.
- El equipo se comunicará con usted en un plazo de 7 a 10 días hábiles para darle los resultados de la patología. Esto se revisará en la cita posoperatoria.

¿Cuándo debo comunicarme con el enfermero o el médico?

- Cuando tiene un sangrado o una secreción que empapa el vendaje.
- Temperatura tomada por vía oral de 100.4 °F (38 °C) o más
- Temperatura tomada debajo del brazo de 99.5 °F (37.5 °C) o más
- Tiene escalofríos, con o sin fiebre.
- Tiene alguna señal de infección: enrojecimiento, aumento del dolor, hinchazón, drenaje con mal olor o aumento en la cantidad de drenaje de la herida.
- Cuando tiene un drenaje debajo del brazo y tiene preguntas después de revisar la sección “Cuidado del drenaje” de esta guía.
- Cuando nota un aumento en la inflamación de la piel en el lugar donde está/estaba el drenaje.
- Cuando tiene náuseas y vómitos.
- Cuando tiene preocupaciones que no pueden esperar hasta la visita de seguimiento.

Estiramientos y ejercicios: Después de la tumorectomía o biopsia del nódulo linfático centinela (SLNB)

Estos son estiramientos y ejercicios para hacer después de la tumorectomía o SLNB.

¿Por qué necesito hacer estos estiramientos y ejercicios?

Estos estiramientos y ejercicios ayudan a:

- Normalizar lentamente el movimiento del brazo (rango de movimiento).
- Mejorar su postura.
- Relajar cualquier área tensa en el pecho y la axila.

Cuándo empezar

- Intente empezar los estiramientos y los ejercicios uno o dos días después de la operación. Hágalos **suavemente** hasta que vea a un fisioterapeuta/terapeuta ocupacional (PT/OT). El PT/OT creará un plan de ejercicios basado en cómo usted se está recuperando.

Directrices para el ejercicio

- Use gradualmente el brazo durante las actividades de cuidado personal (vestirse, bañarse, comer). Deje de hacerlo si siente dolor o tensión. Si el dolor continúa, llame al equipo quirúrgico.
- Lea atentamente el CareMap o las instrucciones para después de la operación para obtener información sobre cómo cuidarse mientras se recupera de la operación.
- Haga todos los ejercicios lentamente y solo como se lo recomendaron.
- Respire lenta y profundamente mientras hace cada ejercicio.
- Céntrese en la curación después de la operación. Permítase sentir un suave estiramiento. **Deténgase y descansa si siente dolor.** Tome acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Advil®) según lo recetado si continúa el dolor.
- Su equipo de atención puede recomendar que usted consulte con un PT/OT a partir de unas 4 semanas después de la operación. Ayudarán a mejorar su rango de movimiento y a recuperar su fuerza.

Después de la operación

Siga las directrices de actividad de su equipo de atención. Durante y después de cada actividad, revise su brazo para ver si tiene:

- Hinchazón
- Sensación de:
 - Llenura
 - Dolor
 - Pesadez
 - Firmeza

Si nota alguno de estos síntomas, descansa y eleve el brazo. Haga una rutina de estiramientos y ejercicios más sencilla al día siguiente. Llame al equipo quirúrgico si los síntomas no desaparecen en 2 o 3 días.

Ejercicios

Intente comenzar estos ejercicios uno o dos días después de la operación. Haga los ejercicios en el orden en que se mencionan en este folleto. Hágalos despacio y deténgase si siente dolor.

- **Día 1:** Haga los ejercicios del 1 al 3 lo mejor que pueda.
- **Día 2:** Si puede hacer los ejercicios 1-3, añada 1-2 ejercicios más.
- **Cada día después:** Continúe agregando 1-2 ejercicios más cada día hasta que pueda hacerlos todos.

Haga toda la serie de ejercicios hasta que se reúna con un PT/OT o el movimiento del brazo vuelva a ser normal.

1. Caminar

Caminar puede ayudar a que el corazón y los pulmones funcionen mejor, aumenta la energía y mejora el estado de ánimo.

- Camine al menos 4 veces al día.
- Comience con caminatas de aproximadamente 10 a 15 minutos.

2. Practique una buena postura

Esto ayuda a mejorar la respiración y evita la rigidez y la tensión en los músculos del pecho, el cuello, la espalda y los hombros.

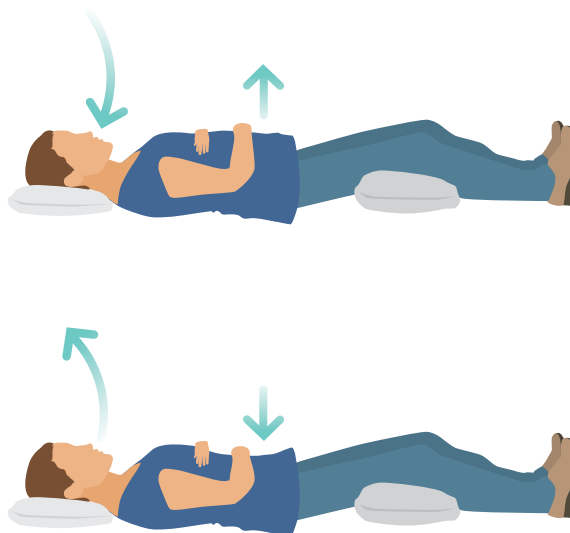
1. Párese recto y erguido con los brazos relajados a los lados del cuerpo.
2. Evite arquear los hombros y encorvarse. Mantenga los hombros hacia abajo y relajados.
3. No empuje la cabeza hacia delante o hacia atrás. Mantenga la cabeza nivelada con los lóbulos de las orejas alineados con los hombros.
4. Corrija la postura con frecuencia durante el día.



3. Respiración con el vientre

Este ejercicio ayuda a relajarse, reduce el estrés y mejora la circulación linfática.

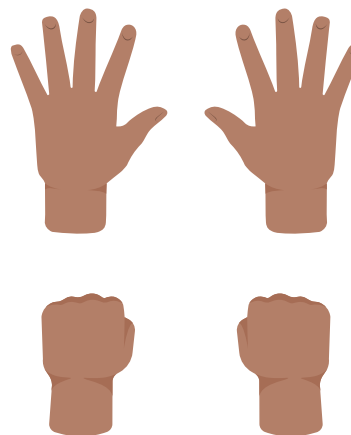
1. Acuéstese sobre la espalda con las rodillas dobladas y la cabeza apoyada.
2. Coloque una mano en la parte superior del pecho y la otra justo por debajo de la caja torácica.
3. Inhale lentamente por la nariz para que el estómago se mueva suavemente hacia fuera contra su mano. La mano en la parte superior del pecho debe permanecer quieta. No se esfuerce.
4. Al exhalar por la boca, deje que el estómago se hunda y vuelva a la posición de reposo.
5. Repita de 5 a 10 veces, 1 a 2 veces al día.



4. Movimiento de la mano

Este ejercicio ayuda a la circulación linfática y a la rigidez de la mano.

1. Comience con los dedos rectos y separados.
2. Cierre suavemente la mano en un puño.
3. Abra y separe los dedos.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



5. Movimiento del codo

Este ejercicio ayuda con la circulación linfática, la rigidez del codo y disminuye la rigidez en el brazo.

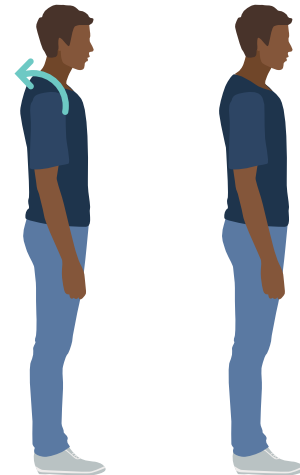
1. Siéntese o acuéstese con el brazo apoyado.
2. Doble y estire el codo.
3. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



6. Giros de hombros

Este ejercicio ayuda a disminuir la rigidez en la parte superior de la espalda y mejora la postura.

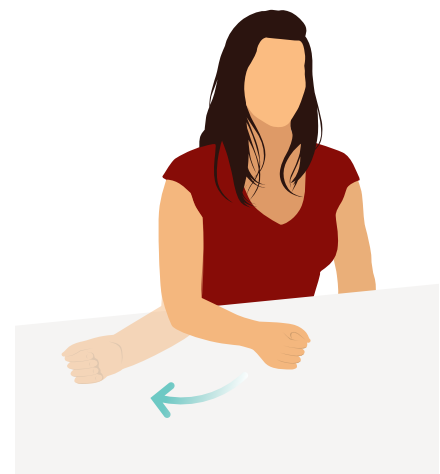
1. De pie o sentado, con los brazos relajados a los lados.
2. Levante los hombros hacia las orejas y gírelos hacia atrás.
3. Regrese a la posición inicial.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



7. Rotación de hombros

Este ejercicio ayuda a reducir la tensión/rigidez en el hombro.

1. Siéntese o póngase de pie con el brazo apoyado en una posición cómoda sobre una mesa o encimera.
2. Tenga el codo en el costado y doblado en un ángulo de 90 grados como en la imagen.
3. Gire el brazo hacia fuera y hacia dentro mientras mantiene el codo en el costado.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.

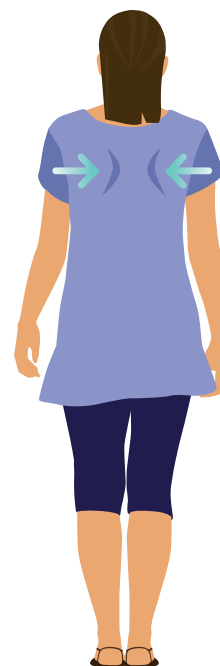


8. Apretones del omóplato

Este ejercicio activa los músculos que ayudan con una buena postura y relaja los músculos tensos del pecho.

1. Póngase de pie o siéntese en una silla. Los brazos deben estar relajados en los costados.
2. Apriete suavemente los omóplatos, llevando los codos ligeramente hacia atrás.
3. Regrese a la posición inicial.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.

Nota: Evite encoger los hombros hacia las orejas mientras hace este ejercicio.



9. Estiramiento de hombros en posición acostada

Este ejercicio ayuda a mejorar el rango de movimiento de los hombros, con el objetivo de elevar los brazos por encima de la cabeza.

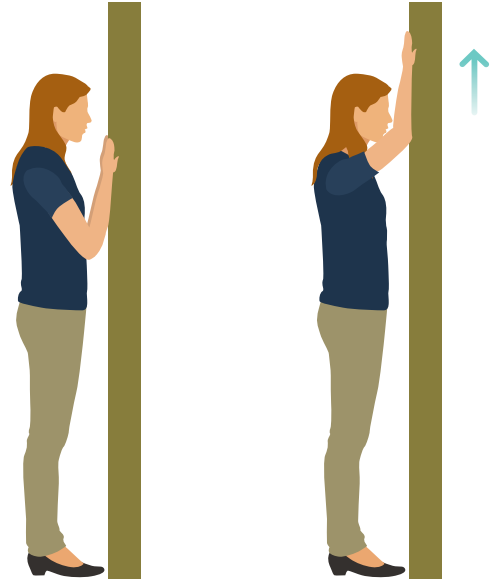
1. Acuéstese con las rodillas dobladas y los pies planos. Ponga una almohada debajo de su cabeza o debajo de sus rodillas si eso lo hace sentir más cómodo.
2. Sujétese la muñeca (del lado de la operación) con la mano contraria para guiar suavemente el movimiento.
3. Levante lentamente los brazos por encima de la cabeza, liderando con los pulgares, mientras mantiene los codos lo más rectos que pueda.
4. Mantenga la posición durante 5 segundos.
5. Regrese a la posición inicial.
6. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



10. Estiramiento de hombros de pie

Este ejercicio ayuda a mejorar el rango de movimiento de los hombros, con el objetivo de elevar los brazos por encima de la cabeza.

1. Póngase de pie frente a una pared con los dedos de los pies a unas 8 a 10 pulgadas de la pared.
2. Coloque ambas manos en la pared.
3. Moviendo las manos a la misma velocidad, “suba” los dedos por la pared llegando tan alto como pueda hasta que sienta un suave estiramiento.
4. Evite arquear la espalda mientras sube los dedos por la pared.
5. Mantenga la posición durante 5 segundos.
6. Vuelva a bajar el brazo a la posición inicial.
7. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



Mastectomía

La mastectomía es una operación que implica la extirpación de todo el tejido mamario para tratar o prevenir el cáncer de mama. La operación para restaurar la forma de la mama, llamada reconstrucción mamaria, es opcional y se puede hacer al mismo tiempo que la mastectomía o durante una segunda operación en una fecha posterior.

Antes del procedimiento

- Lea atentamente la sección “Sobre la experiencia con la operación” en esta guía y siga las instrucciones que se dan.
- En la visita preoperatoria le recetarán una camisola posoperatoria. Deberá probarse la camisola antes de la operación.

Extirpación de los nódulos linfáticos

En algunos casos, es necesario extirpar ciertos nódulos linfáticos que están debajo del brazo para determinar si el cáncer se propagó. Hay dos opciones habituales de extirpación:

- **Biopsia del nódulo linfático centinela:** Los nódulos centinela son los nódulos linfáticos situados más cerca del cáncer y son los primeros en drenar la linfa de la mama. Estos nódulos, situados en la axila, son también los primeros a los que podría propagarse el cáncer. Cada persona tiene un promedio de 2 a 3 nódulos centinela. Los nódulos linfáticos extirpados se examinarán minuciosamente en busca de células cancerosas. Durante la operación, el cirujano le inyectará una pequeña cantidad de material radiactivo (también llamado radiotrazador) y un colorante azul debajo del pezón. El material radiactivo viajará por sus vasos linfáticos hasta los nódulos linfáticos centinela.

El tinte azul ayuda al cirujano a identificar qué nódulos hay que extirpar. Con un equipo especial, el cirujano localizará y extirpará los nódulos que contienen el material radiactivo. El tinte decolorará temporalmente la piel y la orina durante unas 24 horas.

- **Disección de los nódulos linfáticos axilares:** Este procedimiento implica extirpar la mayor parte o la totalidad de los nódulos linfáticos que están debajo del brazo. El cirujano puede recomendar este procedimiento si una biopsia de los nódulos linfáticos muestra que el cáncer se propagó.

Durante el procedimiento

La mastectomía y cualquier operación de los nódulos linfáticos se hacen con anestesia general, por lo que estará dormida y sin conocimiento durante el procedimiento.

El cirujano hará una incisión para extirpar los nódulos linfáticos y otra para extirpar la mama. Estas incisiones se cerrarán con puntos de sutura que se disolverán solos.

Por cada mama que se extirpe, se pondrán de 1 a 2 drenajes debajo de la piel durante el procedimiento. Le enseñarán a usar los drenajes en casa antes de salir del hospital.

Después del procedimiento

- Su vendaje se hará de Steri-Strips (cinta médica que cubre la incisión), además de otro vendaje externo. El lugar del drenaje puede tener o no un vendaje. También es posible que le coloquen un vendaje ACE alrededor del pecho para darle más soporte.
- Puede usar la camisola posoperatoria o el sostén quirúrgico si le dan uno, después de la operación durante el tiempo que quiera.
- Le enseñarán a usar los drenajes en casa antes de salir del hospital.
- Puede pasar a la farmacia del hospital antes de salir para recoger una receta de analgésicos.
- Quite todas las capas de vendaje, excepto las Steri-Strips, 48 horas después de la operación.
- Puede ducharse después de que le quiten las capas de vendaje. No pasa nada si las Steri-Strips se mojan en la ducha.
- Quite y vacíe los drenajes dos veces al día (o con más frecuencia si es necesario). Consulte la sección “Cuidado del drenaje” en esta guía para obtener más información y los registros de salida de los drenajes.
- Traiga los registros de los drenajes a la cita después de la operación. Los drenajes se quitarán una vez que la secreción cumpla las siguientes directrices:
 - Para operación sin reconstrucción, la secreción es inferior a 30 mL cada 24 horas durante 2 días seguidos, pero no antes de una semana después de la operación.
 - Para operación con reconstrucción, la secreción es inferior a 20 mL cada 24 horas durante 2 días seguidos, pero no antes de una semana después de la operación.

Después del procedimiento, continuación

Si no tiene claro cuándo deben quitar sus drenajes, llame a su equipo de atención.

- Siga las instrucciones de actividad que aparecen en el CareMap o en la documentación del alta.
- Reanude su dieta habitual después de la operación. Intente prevenir el estreñimiento aumentando los líquidos y la fibra en la dieta. Consulte la sección “Estreñimiento después de la operación” para obtener más información de cómo prevenir este problema frecuente.
- Siga tomando los medicamentos habituales según se lo recetaron después de la operación.
- Le programarán que regrese a la clínica para la cita posoperatoria aproximadamente entre 7 y 14 días después de la operación.
- El equipo se comunicará con usted en un plazo de 7 a 10 días hábiles para darle los resultados de la patología. Esto se revisará en la cita posoperatoria.

¿Cuándo debo llamar al enfermero o al médico?

- Cuando tiene un sangrado o una secreción que empapa el vendaje.
- Temperatura tomada por vía oral de 100.4 °F (38 °C) o más
- Temperatura tomada debajo del brazo de 99.5 °F (37.5 °C) o más
- Tiene escalofríos, con o sin fiebre.
- Tiene alguna señal de infección: enrojecimiento, aumento del dolor, hinchazón, drenaje con mal olor o aumento en la cantidad de drenaje de la herida.
- Cuando tiene un drenaje debajo del brazo y tiene preguntas después de revisar el folleto “Cuidado del drenaje” en esta guía.
- Cuando nota un aumento en la inflamación de la piel en el lugar donde está/estaba el drenaje.
- Cuando tiene náuseas y vómitos.
- Cuando tiene preocupaciones que no pueden esperar hasta la visita de seguimiento.

Cuidado del drenaje

Después de la operación, tendrá colocado un drenaje de bulbo cerrado, llamado drenaje Jackson-Pratt (JP). La información de abajo explica cómo cuidar los drenajes en casa hasta que estén listos para quitarlos.

¿Por qué tengo drenajes?

Los drenajes JP son drenajes de bombilla cerrados que recolectan el líquido del lugar de la operación. Esto ayuda a evitar que la sangre y los fluidos corporales se acumulen debajo de la piel y causen hinchazón. También ayuda a la cicatrización de la herida. Los tubos de drenaje atraviesan la piel cerca de la incisión quirúrgica. Se mantienen en su lugar mediante un punto (sutura).

Para ver un video sobre cómo cuidar su drenaje, escanee el código QR o visite FredHutch.org/videos-breast-cancer y haga clic en “Caring for Your Closed Bulb Drain at Home” (Cómo cuidar su drenaje de bulbo cerrado en casa)



Mientras tenga drenajes:

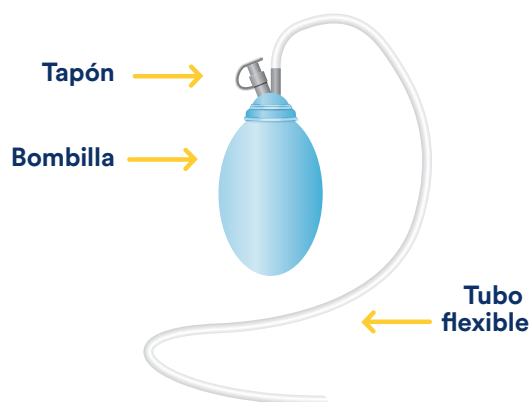
- Vacíe cada bombilla/recipiente de recolección al menos 2 veces al día: en la mañana y antes de acostarse. Vacíe cada bombilla con más frecuencia según sea necesario, siempre que esté $\frac{1}{3}$ llena. Consulte “Cómo vaciar los drenajes” en la página siguiente.
- Es normal que el color del drenaje cambie. Puede ser café, rojo oscuro, rojo, naranja, rosa, amarillo y transparente.
- Quite el tubo de drenaje al menos 2 veces al día. Siga las instrucciones de la sección “Cómo quitar los drenajes” de esta guía para aprender a hacerlo.
- A partir de las **48 horas después de la operación**, dúchese todos los días. Deje correr el agua jabonosa sobre los lugares del drenaje. **No** frote.
- Cuando no esté en la ducha, mantenga limpia y seca el área donde salen los drenajes del cuerpo.

Para evitar infecciones, **no**:

- Desconecte la bombilla del tubo de drenaje.
- Perfore, corte ni introduzca nada en el tubo o en la bombilla.

Las partes de un drenaje JP

La imagen de la derecha muestra las partes principales del drenaje. El tapón es la “tapa” de la “boquilla”. La boquilla es por donde se vierte el líquido cuando se vacía el drenaje.



Registrar el drenaje

- Recibirá una taza para medir cuando deje el hospital. Úsela para medir las secreciones.
- Etiquete los drenajes con los números 1 y 2 para llevar el registro de la secreción de cada uno.

Cómo vaciar los drenajes

Vacíe cada drenaje al menos 2 veces al día o cuando esté $\frac{1}{3}$ lleno. Para vaciar un drenaje:

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón.
2. Afloje los pasadores de seguridad o sujetadores que aseguran el tubo a la ropa.
3. Quite el tubo (consulte “Cómo quitar el drenaje” abajo).
4. Limpie el tapón y la boquilla con una toallita con alcohol.
5. Abra el tapón del drenaje.
6. Coloque el recipiente de recolección del drenaje hacia abajo sobre la taza para medir. Apriete suavemente la bombilla para vaciarla en la taza.
7. Vuelva a limpiar el tapón y la boquilla con una toallita con alcohol.
8. Apriete la bombilla con la mano. Vuelva a poner el tapón en la boquilla.



Cómo vaciar los drenajes (continúa)

9. **Nunca** apriete la bombilla después de poner el tapón en su lugar. Hacer esto puede empujar el drenaje hacia la herida.
10. Mire en el lateral de la taza medidora para ver cuánto líquido drenó. Apunte esta cantidad, en mililitros (mL), en sus hojas de registro de drenaje al final de esta sección.
11. Revise el color y el olor del drenaje.
12. Vacíe el drenaje en el inodoro y tire de la cadena.
13. Sujete con un gancho o un broche la bombilla de drenaje a la ropa.
14. Lávese las manos con agua tibia y jabón.

Baño

- No **se** bañe, ni se siente en un jacuzzi, ni vaya a nadar mientras tenga los drenajes.
- Dúchese después de tener colocados los drenajes durante 48 horas.
 - Si tiene un vendaje quirúrgico exterior, quíteselo antes de ducharse.
 - Mantenga los drenajes en su lugar cuando esté en la ducha, sujételos a una correa o a un cordón de zapato limpio enrollado sin apretar alrededor del cuello.
 - Evite que los tubos de drenaje se caigan en la ducha evitando que cuelguen holgadamente. Sujete los drenajes con una mano o colóquelos en algún lugar cerca de usted donde no se caigan.

Cómo quitar los drenajes

Quitar los drenajes evitará que se obstruyan. Para quitar los drenajes:

1. Use una mano para envolver el tubo con una toallita con alcohol cerca de donde entra en su piel o en el vendaje.
2. Con la otra mano, sujete firmemente el tubo justo encima de la toallita con alcohol para mantenerlo firme.
3. Con la primera mano, apriete la sección del tubo que cubre la toallita con alcohol. Mantenga esta presión mientras desliza la toallita por el tubo hasta la bombilla y luego suéltela.
4. Repita los pasos 1–3 2–3 veces más usando una toallita con alcohol nueva cada vez.

Cuándo los drenajes están listos para quitarlos

Su equipo de atención le dirá cuándo estará listo el drenaje para quitarlo. A menudo, los drenajes están listos para quitarlos cuando tiene menos de 30 mL de drenaje cada 24 horas durante dos días seguidos.

Cuando los drenajes estén listos para quitarlos, llame al equipo de atención de Fred Hutch y dígales que los drenajes están listos para quitarlos y pida que programen una visita de enfermería. Traiga los registros de los drenajes a la visita.

Cuándo buscar ayuda

Llame al equipo de atención si:

- Tiene enrojecimiento, hinchazón o secreción en el lugar de la incisión o del drenaje.
- Recolecta más de 150 mL de drenaje en un período de 24 horas y el drenaje tiene sangre.
- La bombilla/el recipiente de recolección se llena de sangre o drenaje justo después de vaciarlo.
- Tiene más dolor de lo habitual o los analgésicos no alivian el dolor.
- La bombilla de drenaje no se mantiene comprimida.
- El drenaje es turbio o tiene mal olor.
- El tubo se cae.
- Se sale un punto de sutura.
- Tiene escalofríos, con o sin fiebre.
- Temperatura tomada por vía oral de 100.4 °F (38 °C) o más
- Temperatura tomada debajo del brazo de 99.5 °F (37.5 °C) o más

[illegible]

Registro para el drenaje 2

[illegible]

Estiramientos y ejercicios: Después de su mastectomía o disección de ganglios linfáticos axilares (ALND) con o sin LYMPHA

Estos son estiramientos y ejercicios para hacer después de la mastectomía o ALND, con o sin cirugía LYMPHA.

¿Por qué necesito hacer estos estiramientos y ejercicios?

Estos estiramientos y ejercicios ayudan a:

- Normalizar lentamente el movimiento del brazo (rango de movimiento)
- Mejorar su postura
- Relajar las áreas tensas en el pecho y las axilas

Cuándo empezar

Intente empezar los estiramientos y ejercicios uno o dos días después de la operación. Hágalos hasta que consulte a un fisioterapeuta/terapeuta ocupacional (PT/OT) o hasta que el movimiento del brazo vuelva a ser normal. El PT/OT creará un plan de ejercicios basado en cómo se está recuperando.

Restricciones de actividad

- No levante el brazo del lado de la operación por encima de los hombros hasta que quiten los drenajes y el equipo de atención le diga que es seguro. Esto suele ocurrir entre 3 y 4 semanas después de la operación.
- No empiece el entrenamiento de resistencia hasta que su equipo de atención le diga que es seguro hacer esta actividad.
- Revise cuidadosamente el CareMap o las instrucciones después de la operación para conocer otras restricciones de actividad.

Después de la operación

Continúe con las restricciones de actividad que le dio su equipo de atención. Durante y después de cada actividad, revise su brazo para ver si tiene:

- Hinchazón
- Sensación de:
 - Inflamación
 - Pesadez
 - Dolor
 - Turgencia

Después de la operación, continuación

Si nota alguno de estos síntomas, descanse y eleve el brazo. Haga una rutina de estiramientos y ejercicios más sencilla al día siguiente. Llame al equipo quirúrgico si los síntomas no desaparecen en 2 o 3 días.

Directrices para el ejercicio

- Haga todos los ejercicios lentamente y solo como se lo recomendaron.
- Respire lenta y profundamente mientras hace cada ejercicio.
- Céntrese en sanar después de su operación. Permítase sentir un suave estiramiento. **Deténgase y descanse si siente dolor.** Tome acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil®) según lo recetado si el dolor continúa.
- Consulte a un PT/OT especialista en cáncer de mama aproximadamente 1 semana después de que le hayan quitado el último drenaje. Lo ayudarán a mejorar su rango de movimiento y a reconstruir su fuerza. Pregúntele a su equipo de atención sobre el PT/OT si aún no lo han remitido.

Ejercicios

Intente comenzar estos ejercicios uno o dos días después de la operación. Haga los ejercicios en el orden en que se mencionan en este folleto. Hágalos despacio y deténgase si siente dolor.

- **Día 1:** Haga los ejercicios del 1 al 3 lo mejor que pueda.
- **Día 2:** Si puede hacer los ejercicios del 1–3, agregue 1–2 ejercicios más.
- **Cada día después:** Continúe agregando 1–2 ejercicios más cada día hasta que pueda hacerlos todos.
- Espere a hacer los ejercicios 11 y 12 hasta que le quiten los drenajes y su equipo de atención le diga que es seguro.

Haga toda la serie de ejercicios hasta que se reúna con un PT/OT o el movimiento del brazo vuelva a ser normal.

1. Caminar

Caminar puede ayudar a que el corazón y los pulmones funcionen mejor y también aumenta la energía y mejora el estado de ánimo.

- Camine al menos 4 veces al día.
- Comience con caminatas de aproximadamente 10 a 15 minutos.

2. Practique una buena postura

Esto ayuda a mejorar la respiración y a prevenir la rigidez y la tensión en los músculos que rodean el pecho, el cuello, la espalda y el hombro.

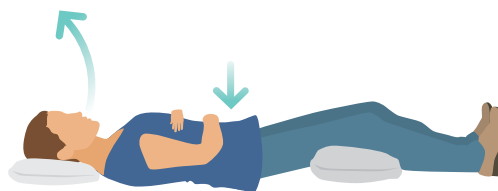
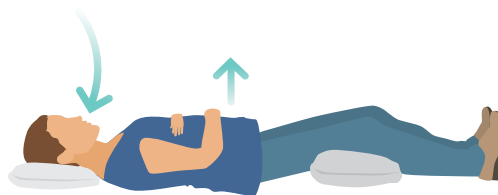
1. Párese recto y erguido con los brazos relajados a los lados del cuerpo.
2. Evite arquear los hombros y encorvarse. Mantenga los hombros hacia abajo y relajados.
3. No empuje la cabeza hacia delante o hacia atrás. Mantenga la cabeza nivelada con los lóbulos de las orejas alineados con los hombros.
4. Corrija la postura con frecuencia durante el día.



3. Respiración con el vientre

Este ejercicio lo ayuda a relajarse, reduce el estrés y mejora la circulación linfática.

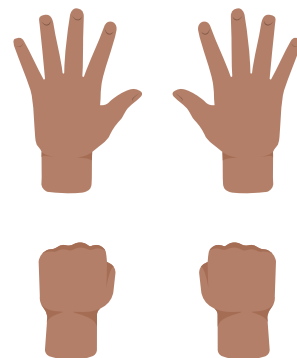
1. Acuéstese sobre la espalda con las rodillas dobladas y la cabeza apoyada.
2. Coloque una mano en la parte superior del pecho y la otra justo por debajo de la caja torácica.
3. Inhale lentamente por la nariz para que el estómago se mueva suavemente hacia fuera contra su mano. La mano en la parte superior del pecho debe permanecer quieta. No se esfuerce.
4. Al exhalar por la boca, deje que el estómago se hunda y vuelva a la posición de reposo.
5. Repita de 5 a 10 veces, 1 a 2 veces al día.



4. Movimiento de la mano

Este ejercicio ayuda a la circulación linfática y a la rigidez de la mano.

1. Comience con los dedos rectos y separados.
2. Cierre suavemente la mano en un puño.
3. Abra y separe los dedos.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



5. Movimiento del codo

Este ejercicio ayuda con la circulación linfática, la rigidez del codo y disminuye la rigidez en el brazo.

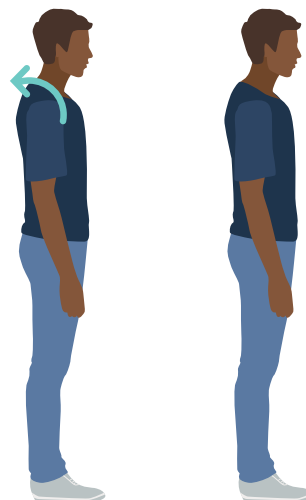
1. Siéntese o acuéstese con el brazo apoyado.
2. Doble y estire el codo.
3. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



6. Giros de hombros

Este ejercicio ayuda a disminuir la rigidez en la parte superior de la espalda y mejora la postura.

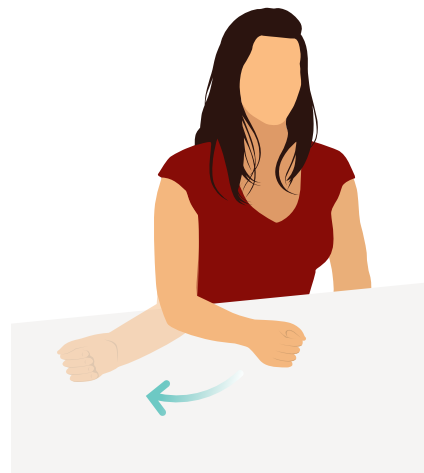
1. Párese o siéntese con los brazos relajados a los lados.
2. Levante los hombros hacia las orejas y gírelos hacia atrás.
3. Regrese a la posición inicial.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces/día.



7. Rotación de hombros

Este ejercicio ayuda a reducir la tensión/rigidez en el hombro.

1. Siéntese o póngase de pie con el brazo apoyado en una posición cómoda sobre una mesa o encimera.
2. Ponga su codo al lado de su cuerpo y dóblelo en un ángulo de 90 grados como en la imagen.
3. Gire el brazo hacia fuera y hacia dentro mientras mantiene el codo en el costado.
4. Repita 10 veces, 1–2 veces/día.

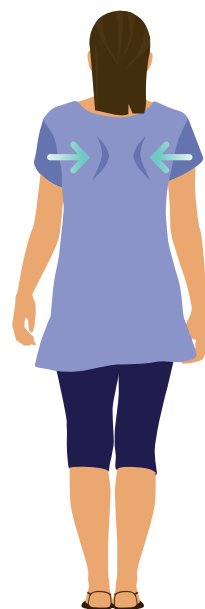


8. Apretones del omóplato

Este ejercicio activa los músculos que ayudan con una buena postura y relaja los músculos tensos del pecho.

1. Párese o siéntese en una silla con los brazos relajados a los lados.
2. Apriete suavemente los omóplatos, llevando los codos ligeramente hacia atrás.
3. Regrese a la posición inicial.
4. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.

Nota: Evite encoger los hombros hacia las orejas mientras hace este ejercicio.

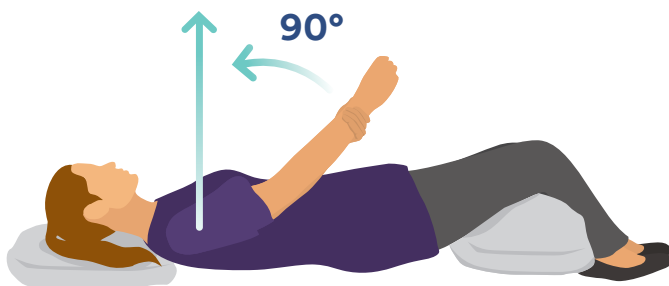


9. Estiramiento de hombros en posición acostada

Este ejercicio ayuda a mejorar el rango de movimiento de los hombros, con el objetivo de elevar los brazos por encima de la cabeza.

1. Acuéstese con las rodillas dobladas y los pies planos. Ponga una almohada debajo de la cabeza o debajo de las rodillas si esto lo hace sentir más cómodo.
2. Sujétese la muñeca (del lado de la operación) con la mano contraria para guiar suavemente el movimiento.
3. Levante lentamente los brazos manteniendo los codos lo más rectos que pueda. Levante los brazos para que estén alineados con los hombros. No levante el brazo por encima del hombro (90 grados) del lado de la operación.
4. Mantenga la posición durante 5 segundos.
5. Regrese a la posición inicial.
6. Repita 10 veces, 1–2 veces al día.

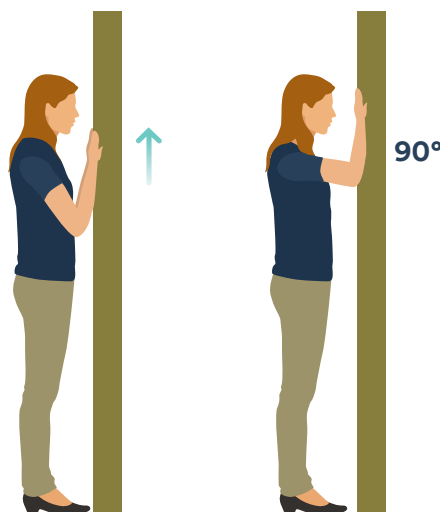
Nota: Pueden pasar varios días hasta que pueda levantar los brazos a la altura de los hombros como se describió arriba. Establezca objetivos de movimiento con su equipo de atención o PT/OT.



10. Estiramiento de hombros de pie

Este ejercicio ayuda a mejorar el rango de movimiento de los hombros, con el objetivo de elevar los brazos por encima de la cabeza.

1. Póngase de pie frente a una pared con los dedos de los pies a unas 8–10 pulgadas de la pared.
2. Ponga ambas manos en la pared.
3. Moviendo las manos a la misma velocidad, "suba" los dedos por la pared. Deténgase cuando los codos estén a la altura de los hombros. No levante los brazos por encima de los hombros (90 grados).
4. Evite arquear la espalda mientras sube los dedos por la pared.
5. Mantenga la posición durante 5 segundos.
6. Vuelve a bajar los brazos a la posición inicial.
7. Repita 10 veces, 1–2 veces al día.



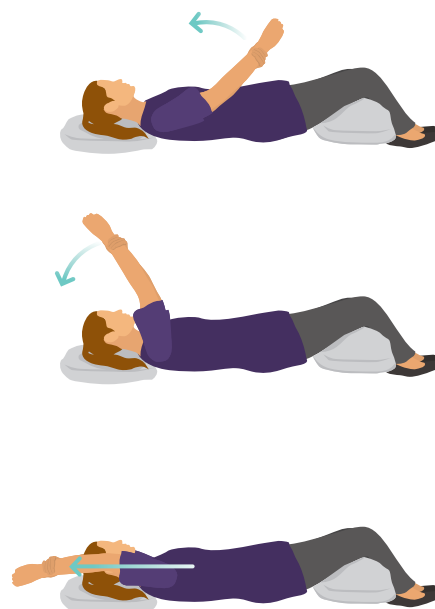
Ejercicios para hacer después de que se quiten los drenajes

Solo haga estos ejercicios después de que le hayan quitado los drenajes y que su equipo de atención diga que es seguro (normalmente entre 3 y 4 semanas después de la operación). Siga haciéndolos hasta consulte con un PT/OT. Su PT/OT creará un plan de ejercicios para usted basado en cómo se esté recuperando de la operación.

11. Estiramiento de hombros en posición acostada

Este ejercicio ayuda a mejorar el rango de movimiento de los hombros, con el objetivo de elevar los brazos por encima de la cabeza.

1. Acuéstese con las rodillas dobladas y los pies planos. Ponga una almohada debajo de la cabeza o debajo de las rodillas si esto lo hace sentir más cómodo.
2. Sujétese la muñeca (del lado de la operación) con la mano contraria para guiar suavemente el movimiento.

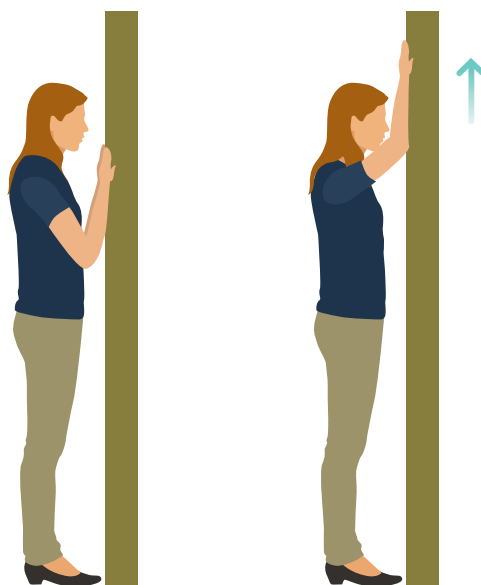


3. Levante lentamente los brazos por encima de la cabeza, liderando con los pulgares, mientras mantiene los codos lo más rectos que pueda.
 4. Mantenga la posición durante 5 segundos.
 5. Regrese a la posición inicial.
 6. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.
- Nota: Pueden pasar varios días hasta que pueda levantar los brazos por encima de la cabeza como se describió arriba. Establezca objetivos de movimiento con su equipo de atención o PT/OT.

12. Estiramiento de hombros de pie

Este ejercicio ayuda a mejorar el rango de movimiento de los hombros, con el objetivo de elevar los brazos por encima de la cabeza.

1. Póngase de pie frente a una pared con los dedos de los pies a unas 8 a 10 pulgadas de la pared.
2. Coloque ambas manos en la pared.
3. Moviendo las manos a la misma velocidad, "suba" los dedos por la pared llegando tan alto como pueda hasta que sienta un suave estiramiento.
4. Evite arquear la espalda mientras sube los dedos por la pared.
5. Mantenga la posición durante 5 segundos.
6. Vuelve a bajar los brazos a la posición inicial.
7. Repita 10 veces, 1 a 2 veces al día.



Atención después de la operación

Administración de los medicamentos de apoyo

¿Qué es un medicamento de apoyo?

Los medicamentos de apoyo son una forma de ayudar a manejar algunos efectos secundarios del cáncer y el tratamiento. Es importante que le informe al equipo de atención médica si los efectos secundarios no están bien manejados para que puedan ayudarlo. Lo ayudarán a encontrar la mejor manera de manejar los efectos secundarios según la causa.

Lo que debe saber

Su equipo de atención lo monitoreará para detectar efectos secundarios mientras esté tomando medicamentos de apoyo. Mientras esté tomando estos medicamentos, es importante que:

- **Nos diga los nombres de todos los medicamentos, suplementos y otras sustancias,** como alcohol, cannabis o drogas ilegales, que esté tomando.
- **Hable con su equipo antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, suplemento u otra sustancia nueva.** Estos pueden causar problemas graves si se toman junto con sus medicamentos contra el cáncer.
- **Lleve un registro de las dosis diarias.** Anote la fecha y la hora a la que toma sus medicamentos de apoyo. Esto puede ayudarlo a saber cuándo es el momento de tomar su próxima dosis.
- **Llame al equipo de atención si un medicamento no está ayudando.** Por su seguridad, no tome más medicamento del que le recetaron sin consultar antes con su equipo de atención médica.
- **Prepárese para los efectos secundarios frecuentes.** Los efectos secundarios de los medicamentos de apoyo pueden incluir estreñimiento, náuseas, boca seca y somnolencia. Informe a su equipo de atención médica si los tiene para que puedan ayudarlo a manejar estos efectos secundarios.
- **Llame a su equipo de atención al menos 5 días hábiles antes de que se acabe su receta** para que tenga el medicamento cuando lo necesite.
- **Hable con su equipo de atención antes de dejar de tomar medicamentos.** Algunos medicamentos de apoyo producen síndrome de abstinencia, como dolores corporales, sudoración, ansiedad y diarrea, si los suspende repentinamente. Su equipo de atención le ayudará a crear un plan para dejar de tomar estos medicamentos lentamente.

Atención después de la operación: lo que debe saber (continúa)

- **Guarde todos los medicamentos en un lugar seguro y no los comparta con nadie.** Los medicamentos pueden hacerles daño a los niños, a las mascotas o a otras personas que no sean la persona para quien se recetaron.
- **Deshágase de manera segura de los medicamentos antiguos o que no use.** Los analgésicos opioides y algunos medicamentos para la ansiedad se deben tirar en el inodoro si no puede llevarlos a un quiosco de recolección de medicamentos. Para buscar un quiosco de recolección cerca de usted, visite med-project.org.
- **Informe al equipo de atención si usted u otras personas en su vida sienten que los medicamentos de apoyo le están causando problemas.** Si se siente somnoliento, tiene problemas para mantener el equilibrio o no puede pensar con claridad, hable con su equipo de atención lo antes posible.
- **No conduzca un auto ni opere maquinaria pesada si se siente somnoliento o si su pensamiento está confuso o nublado.** Los medicamentos opioides y otros medicamentos pueden provocar efectos secundarios que hacen que conducir no sea seguro. Afectan a cada persona de manera diferente y conducir bajo sus efectos es ilegal. Si los demás le dicen que les preocupa su capacidad para conducir, tómelos en serio.

Comuníquese con su equipo de atención si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos de apoyo.

Estreñimiento después de la operación

¿Qué es el estreñimiento?

El estreñimiento es cuando es difícil evacuar los intestinos (defecar). Es posible que usted tenga estreñimiento si:

- Sus heces son pequeñas, grumosas, duras o secas
- Tiene dolor o dificultad para evacuar, a menudo con esfuerzo y hemorroides
- Hinchazón, sensación de saciedad e incapacidad para vaciar completamente los intestinos; también puede sentir náuseas

¿Qué causa el estreñimiento?

- Ciertos medicamentos, como analgésicos opioides o anestesia (medicamentos que previenen el dolor durante la operación)
- El cáncer y sus tratamientos
- Cambios en el cuerpo debido a otras condiciones médicas

¿Qué causa el estreñimiento? continuación

- Inactividad o actividad reducida
- Falta de líquidos (deshidratación)
- Cambios en la dieta habitual
- Operación reciente

Lo que puede hacer en casa

Por su seguridad, no tome ningún medicamento para el estreñimiento sin hablar antes con su equipo de atención.

Mantenga la nutrición y el consumo de líquidos

- Beba muchos líquidos para mantenerse hidratado, como agua, jugo, sopa, caldo y licuados. El consumo habitual de líquidos ayuda a evacuar las heces y es especialmente importante a medida que aumenta la fibra en su dieta. Hable con su equipo sobre qué cantidad de líquido es adecuada para usted.
- Aumente la fibra dietética incluyendo vegetales, frutas, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales de forma habitual. Aumente lentamente la cantidad de fibra en su dieta para evitar el exceso de gases o la hinchazón. Consulte la tabla de abajo para obtener sugerencias de comida para el estreñimiento.
- Hable con su equipo de atención sobre los suplementos de fibra, como Metamucil® y Citrucel®, porque algunos empeoran el estreñimiento.
- Intente comer las comidas, especialmente el desayuno, a la misma hora cada día. Esto ayuda a que los intestinos vuelvan a tener un horario habitual.
- Si es posible, incluya ejercicio habitual y a diario. El ejercicio ayuda a que los intestinos se muevan. Incluso caminar lentamente ayudará. Intente caminar de 5 a 15 minutos una o dos veces al día.
- Si quiere ver a un dietista de Fred Hutch, consulte con su equipo de atención. Un dietista puede hablarle sobre la comida que puede ayudar.

Trate el estreñimiento o maneje los síntomas

- Su proveedor puede recetarle medicamentos llamados laxantes para tratar su estreñimiento. A veces se recetan dos o más laxantes juntos. Asegúrese de tomar cada laxante según las indicaciones del equipo de atención.

Trate el estreñimiento o maneje los síntomas, continuación

- Los laxantes que habitualmente se recetan incluyen:
 - **Laxantes osmóticos “de chorro”**, como Polyethylene glycol (MiraLAX® u otras marcas) o lactulosa, que ayudan a ablandar las heces
 - **Laxantes estimulantes de “empuje”**, como Sennoside (Senna) y Bisacodyl (Dulcolax® u otras marcas), que ayudan a mover las heces por el intestino

Los calambres abdominales son un efecto secundario frecuente de ambos tipos de laxantes.

- Si estos laxantes no funcionan, el equipo de atención puede hablar con usted sobre otras opciones, como: citrato de magnesio, Milk of Magnesia® u otros medicamentos con receta.

Precaución: Aunque los supositorios y enemas (medicamentos que se insertan en el recto) están disponibles en la farmacia sin receta, **no los use a menos que se los recete su equipo de atención.** Podrían ser peligrosos para usted.

Cuándo buscar ayuda

Llame **ahora a la clínica o a la clínica fuera de horario** si tiene:

- No ha tenido evacuaciones por 3 días o más
- Náuseas o vómitos incontrolables que le impiden comer o beber
- Distensión en el área abdominal (hinchazón o expansión), dolor en el área abdominal o no puede expulsar gases
- Escape de heces
- Estreñimiento que no mejora en las 24 horas después de tomar los medicamentos como le indicó el equipo de atención
- Dolor de espalda
- Sangrado rectal
- Fiebre
 - Temperatura tomada por vía oral de 100.4 °F (38 °C) o más
 - Temperatura tomada debajo del brazo de 99.5 °F (37.5 °C) o más
 - Tiene escalofríos, con o sin fiebre.

Si desarrolla fiebre, hable con su equipo de atención antes de tomar cualquier medicamento para bajar la fiebre (como acetaminophen/Tylenol® e ibuprofen/Advil® o Motrin®).

Sugerencias de comida para el estreñimiento

Pruebe estos	Limite estos
Granos	
• Panes o muffins integrales y de semillas (con más de 3 gramos de fibra por porción) • Cereales integrales: All Bran®, Fiber One®, Raisin Bran (con más de 3 gramos de fibra por porción) • Cereal integral caliente: avena • Pasta de trigo integral • Arroz silvestre o integral, trigo bulgur, quinoa	• Cenas congeladas, puré de papas instantáneo y papas fritas • Cereales y panes refinados, arroz blanco, pasta normal, pizza • Cereales con bajo contenido de fibra como Rice Krispies®, Corn Flakes
Proteína	
• Legumbres como frijoles, lentejas, guisantes partidos • Yogur (con cultivos vivos) • Combinación de nueces, semillas • Carnes magras • Pescados de agua fría como el salmón salvaje, el halibut y las sardinas	• Grandes cantidades de carne, queso o mantequilla de maní
Frutas y vegetales	
• Vegetales crudos o cocinados: zanahoria, calabaza bellota, espinaca, aguacate, remolacha • Vegetales crucíferos: col, brócoli, coles de Bruselas (coma con moderación si los gases son un problema) • Frutas crudas enteras: manzanas, peras, cerezas, uvas, mandarinas, naranjas, duraznos, ciruelas • Frutas del bosque: frambuesas, arándanos y fresas • Frutos secos: pasas, higos y ciruelas pasas • Jugo de ciruelas pasas	• Bananas
Otro	
• Combinación de frutos secos, snacks integrales • Palomitas de maíz hechas con aire • Líquido	• Cafeína y alcohol • Pasteles, bizcocho dulce, dulces • Dulces concentrados

Referencias/para obtener más información:

American Gastroenterological Association (Asociación Americana de Gastroenterología) - gastro.org
 International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders (Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales) - iffgd.org

Linfedema

Cuando recibe tratamiento para el cáncer de mama (radiación, cirugía de la mama o extirpación de los nódulos linfáticos), puede estar en riesgo de una hinchazón relacionada con la linfa, o "linfedema", en el brazo o la mama del lado que se trató. Esta sección explica el linfedema, cómo puede reducir el riesgo de desarrollarlo y cuándo buscar ayuda.

¿Qué es el linfedema?

El sistema linfático se compone de ganglios linfáticos, órganos y vasos. Su función es eliminar la acumulación de líquido linfático y los desechos de su cuerpo.

Visite: fredhutch.org/lymph-support-services para leer más y ver un video sobre el linfedema.



Ciertos tratamientos para el cáncer de mama, como la radiación, la cirugía y la extirpación de ganglios linfáticos, pueden cambiar la forma en que el líquido linfático fluye en su cuerpo. Estos cambios pueden dificultar que el líquido linfático en el área tratada se mueva a otras partes del cuerpo. Si los vasos linfáticos no pueden eliminar suficiente líquido linfático, este puede acumularse y causar hinchazón leve o grave, llamada linfedema.

El linfedema suele ocurrir en el área del cuerpo que recibió radiación o donde le extirparon ganglios linfáticos. Las personas que tienen muchos ganglios linfáticos extirpados o reciben radiación pueden tener más riesgo de desarrollar linfedema, pero no se entiende completamente por qué algunas personas tienen más probabilidades de desarrollarlo. Cuidar el brazo y la mama puede ayudar a reducir el riesgo.

¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de linfedema?

Las directrices de la página siguiente pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar linfedema e infecciones. Tenga en cuenta que la situación de cada persona es única. Su riesgo de desarrollar linfedema puede variar según su historia de tratamiento contra el cáncer, junto con otros factores de riesgo que pueda tener. Hable con su oncólogo o con un terapeuta certificado en linfedema para saber qué puede hacer para reducir su riesgo de desarrollar linfedema.

Nota: Estas **no son** directrices de prevención. Hay poca investigación sobre cómo reducir el riesgo, por lo que algunas de estas recomendaciones siguen un enfoque de sentido común basado en la estructura del cuerpo y la experiencia de expertos en la materia.

Directrices para reducir el riesgo

Evite lesiones o traumas

- Evite, si es posible, las inyecciones, las extracciones de sangre, las IV y cualquier otra aguja que se introduzca en el brazo donde fue la operación. Esto es especialmente importante si le han hecho una disección de ganglios linfáticos axilares (extirpación de la mayoría o todos los ganglios bajo el brazo) o radiación axilar (radiación bajo el brazo).
- Limpie las heridas/rasguños del brazo con jabón, ponga una pomada antibiótica y un vendaje.
- Use guantes cuando trabaje en el jardín, limpie o use productos que puedan irritar la piel.
- Use protector solar y repelente de insectos según sea necesario.

Evite ejercer presión en el brazo

- Cuando se tome la presión, use el brazo que no ha recibido tratamiento si es posible, especialmente si ha tenido una disección del ganglio axilar o radiación axilar.
- Evite que las correas de su bolso, cartera o mochila se claven en los hombros.
- Evite acostarse sobre el brazo de riesgo, especialmente las semanas después de la operación.

Mantenga un estilo de vida saludable

- Mantenga un peso saludable para reducir la tensión en el sistema linfático.
- Aumente gradualmente el tiempo y la intensidad de las actividades con el brazo. Esto lo ayudará a evitar la tensión muscular.
- Use el brazo en riesgo con normalidad siempre que el dolor sea tolerable y siga las directrices de esta sección.

Hable sobre temperaturas extremas y viajes en avión con su terapeuta certificado en linfedema

- Hasta que hable con su terapeuta certificado en linfedema, evite actividades con temperaturas extremas (como jacuzzis, saunas y baños de vapor).
- Antes de viajar en avión, hable de su riesgo de hinchazón con su terapeuta certificado en linfedema.

Hable sobre las opciones de procedimiento si tuvo una cirugía de ganglios linfáticos bajo ambos brazos.

Pregunte a su médico sobre las opciones para medirle la presión, las extracciones de sangre y cualquier otra aguja, como las IV. Generalmente, recomendamos usar el brazo con la menor cantidad posible de ganglios linfáticos extirpados. A veces se recomienda usar el pie o la pierna para estos procedimientos.

Cuándo buscar ayuda

Es normal tener algo de hinchazón leve durante unos meses después de la operación. Llame a su equipo de atención si tiene alguno de estos síntomas en el área tratada:

- Aumento de la hinchazón, o hinchazón que no desaparece unos meses después de la operación
- Sensación de llenura o pesadez
- Es más difícil ver las venas o los tendones
- Problemas para recuperar la movilidad y la fuerza

El linfedema no es una emergencia, pero una infección puede ser grave. Llame **ahora** a su equipo de atención si tiene **todos** o la **mayoría** de estas señales de infección:

- Síntomas similares a la gripe (fiebre, escalofríos, dolores corporales)
- En el área tratada:
 - Color rosado/enrojecimiento en la piel
 - Dolor
 - Calor
 - Aumento de la hinchazón

Trombosis venosa profunda (TVP)

¿Qué es una TVP?

La trombosis venosa profunda (TVP) es un coágulo de sangre (trombo) que se forma en las venas del cuerpo. La mayoría de TVP se forman en las piernas, arriba o por debajo de la rodilla.

Los problemas médicos relacionados con TVP incluyen las embolias pulmonares (coágulos de sangre en los pulmones) y las tromboembolias venosas (término médico para los coágulos de sangre).

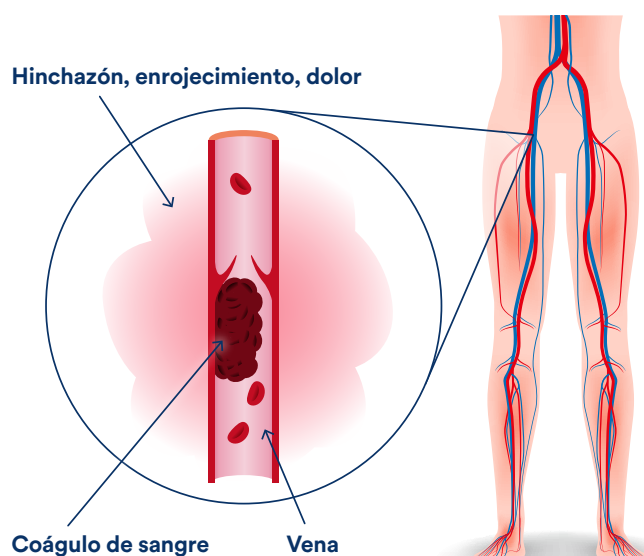
¿Qué causa una TVP?

Las TVP pueden ocurrir:

- Después de una operación o lesión
- Por estar inactivo durante mucho tiempo cuando está en el hospital o postrado en cama
- Después de viajes largos en auto o avión

El riesgo de desarrollar una TVP puede aumentar por algunas enfermedades o por tomar medicamentos que aumentan el riesgo de coagulación de la sangre.

Las TVP también pueden ocurrir sin una causa clara.



TVP en una vena de la pierna

¿Cuáles son las señales de TVP?

La TVP con más frecuencia ocurre en una pierna o un brazo. Las señales más frecuentes incluyen:

- Hinchazón
- Dolor o sensibilidad
- Enrojecimiento o coloración extraña en la piel

¿Por qué es importante prevenir los coágulos de sangre?

Nos tomamos muy en serio la prevención de TVP. Esto se debe a que:

- Las TVP son frecuentes en pacientes que tuvieron una operación o están en el hospital y no pueden moverse mucho.
- Las TVP pueden causar dolor y aumentar el riesgo de desarrollar otro coágulo de sangre en el futuro.

Por qué es importante prevenir los coágulos de sangre (continúa)

- Cuando ocurre una TVP, se necesita más tratamiento, lo que puede alargar la estancia en el hospital.
- Si una TVP no se trata de inmediato, los coágulos de las piernas se pueden romper y desplazar a otras partes del cuerpo. Un coágulo de sangre que se desplaza a los pulmones se llama embolia pulmonar (PE). Este tipo de coágulo puede poner en peligro la vida porque corta el suministro de sangre a los pulmones.

¿Cómo ayudará el equipo de atención a prevenir los coágulos de sangre?

Si está en el hospital durante mucho tiempo, o si ingresa al hospital después de una operación, el equipo de atención usará uno o más métodos para prevenir los coágulos de sangre. Entre estos métodos se incluyen:

Medicamentos anticoagulantes

Pueden administrarle un medicamento para prevenir los coágulos de sangre. Este medicamento puede:

- Administrarse como inyección subcutánea. Los medicamentos inyectables más frecuentes son heparin y Enoxaparin (Lovenox®).
- Tomarse como píldora 1 o 2 veces al día. Los tipos más frecuentes son Warfarin (Coumadin®), Apixaban (Eliquis®) y rivaroxaban (Xarelto®).

Dispositivos de compresión secuencial

Los dispositivos de compresión secuencial (SCD) son vendas que se ponen alrededor de las piernas. De vez en cuando, sentirá que los dispositivos de compresión secuencial se inflan con aire y luego se desinflan. Esto copia la acción de caminar y ayuda a prevenir los coágulos de sangre.

Si tendrá una operación en UW Medical Center, le pondrán estas vendas en las piernas y se encenderán antes de entrar a la sala de operaciones.

Caminar

Caminar poco después de la operación puede ayudar a prevenir los coágulos de sangre. Sin embargo, caminar no es suficiente para prevenir un coágulo de sangre cuando está en el hospital. Lo mejor es que pueda caminar al mismo tiempo que usa otras maneras de prevenir los coágulos de sangre, como usar SCD o tomar medicamentos anticoagulantes.

Pregunte al médico o enfermero qué método para la prevención de coágulos de sangre están usando en su caso.

¿Qué puede hacer para prevenir los coágulos de sangre?

Usted es un miembro importante del equipo de atención. Estas son las cosas que puede hacer para ayudar a prevenir los coágulos de sangre:

- Si tiene alguna señal de TVP, dígaselo al enfermero o al médico inmediatamente.
- Tome cualquier medicamento anticoagulante que le recetaron.
- Use los SCD siempre que esté en la cama o en una silla.
- Levántese de la cama y camine por los pasillos tan pronto y tanto como pueda.
- Antes de levantarse de la cama, pida ayuda para quitarse los SCD.
- Si toma precauciones contra las caídas, pida ayuda antes de levantarse de la cama.
- Haga este simple ejercicio 10 veces cada hora mientras esté despierto (vea el dibujo de abajo):
 - Apunte con los dedos de los pies hacia el extremo de la cama.
 - Luego, apunte con los dedos de los pies hacia la cabeza.



Adaptado con permiso de “Preventing Blood Clots”, ©2017, University of Washington Medical Center, Seattle, WA.

Prevención de caídas

Las personas de cualquier edad con cáncer son más propensas a caerse debido al cáncer o al tratamiento contra el cáncer. También es más probable que se lesionen cuando se caen porque pueden sangrar, tener moretones o fracturarse huesos más fácilmente. Algunas caídas pueden tener como consecuencia lesiones graves, hospitalización o incluso la muerte. Este folleto explica los factores de riesgo frecuentes de las caídas y cómo puede prevenir resbalones, tropiezos y caídas en Fred Hutch Cancer Center y en casa. Su seguridad es nuestra prioridad.

Factores de riesgo de caídas

Los factores que con frecuencia aumentan su riesgo de caídas incluyen:

- Medicamentos, como la quimioterapia y los medicamentos contra la náusea
- Deshidratación (cuando su cuerpo pierde demasiada agua y otros fluidos que necesita para funcionar normalmente)
- Presión baja
- Debilidad muscular o fatiga
- Entumecimiento u hormigueo en las piernas o en los pies
- Sentirse inestable o mareado
- Confusión
- Mala vista o audición

Cómo prevenir caídas en Fred Hutch

Siga estos consejos para ayudar a prevenir caídas en Fred Hutch:

- Siéntese en el borde de la mesa de examen o silla durante un minuto antes de levantarse.
- Traiga su andador, bastón, silla de ruedas o scooter a la clínica.
- Nunca use un soporte para suero IV como apoyo: pida ayuda si necesita mover el soporte para suero.
- Traiga un cuidador que lo acompañe en sus citas.
- Mantenga los zapatos puestos en todo momento en la clínica, incluso cuando esté en la mesa de examen o en la cama.
- Use calzadocerrado en la punta y el talón y que no sea resbaladizo.
- Pida ayuda cuando vaya al baño después de tomar medicamentos porque algunos causan mareos o inestabilidad.
- Use los pasamanos y bancos disponibles en áreas de recepción y pasillos.
- Entre y salga de su auto despacio. Use el servicio de valet parking cuando esté disponible.
- Algunos andadores tienen un asiento para descansar. No mueva el andador mientras esté sentado. Use una silla de ruedas si necesita que lo sienten y lo empujen.
- No se apresure, como cuando entra en un elevador.
- Mantenga sus objetos personales al alcance de la mano.
- Use sus anteojos o aparatos auditivos.

Estamos aquí para ayudarlo

Díganos si:

- Necesita ayuda para caminar.
- Necesita una silla de ruedas.
- Se cayó el año pasado.
- Se tambaleó, tropezó, se sintió mareado, perdió el equilibrio, se sintió inestable al pararse o si sintió debilidad en las piernas.
- Notó si hay pisos resbalosos y mojados o alfombras rotas o levantadas en la clínica.

Si se cae o parece inestable en Fred Hutch, el personal puede ofrecerle una silla de ruedas o usar un elevador mecánico con un arnés para transferirlo.

Cómo prevenir caídas en casa

Use esta lista de verificación para ayudar a prevenir caídas en casa.

Pisos

- ☐ Despeje los pasillos de muebles y objetos. Quite las alfombras si es posible. Si no puede, asegúrelas con una cinta de doble cara.
- ☐ Enrolle o pegue los cables contra la pared.

Escaleras y escalones

- ☐ Quite los objetos de las escaleras.
- ☐ Arregle los escalones sueltos o irregulares.
- ☐ Instale iluminación cenital en la parte superior e inferior de las escaleras.
- ☐ Fije firmemente la alfombra a cada escalón.
- ☐ Arregle los pasamanos sueltos o agregue otros nuevos a cada lado de las escaleras.

Otros consejos útiles

- Sea sincero con su equipo de atención. Dígalos de inmediato si se ha resbalado, tropezado o caído. Ellos pueden ayudarlo a crear un plan para prevenir caídas.
- El ejercicio puede ayudarlo a aumentar su fuerza y resistencia. Pida a su equipo de atención una remisión para Fisioterapia (physical therapy, PT). El PT puede analizar qué ejercicio es seguro para usted y cómo usar un andador o un bastón de manera segura.
- Revise su vista.

Cocina

- ☐ Mueva los objetos frecuentes a los estantes inferiores.
- ☐ Use un taburete con barra de mano. Nunca use una silla.

Baños

- ☐ Use un tapete antiderrapante o tiras autoadhesivas en el piso de la bañera o ducha.
- ☐ Instale barras de apoyo dentro de la bañera y al lado del inodoro.

Dormitorio

- ☐ Coloque una lámpara cerca de la cama.
- ☐ Coloque una luz nocturna junto a la puerta.

General

- ☐ Use muebles con apoyabrazos y asientos más altos. Son más fáciles para sentarse y pararse de manera segura.
- ☐ Use calzado cerrado, con tacón cerrado y antideslizante en la casa.

Cómo tomar fotos de su herida

Este folleto explica cómo tomar fotos de su herida y enviarlas a su equipo de atención.

Consejos para tomar fotos de heridas

Use la luz natural: Tome sus fotos en un lugar bien iluminado. La luz natural es la mejor. Evite la luz fuerte o las sombras. Tome fotos con y sin flash para ver cuál muestra mejor la herida.

Use un fondo uniforme: Si es posible, tenga un fondo uniforme en su foto. Si es necesario, quítese cualquier joya o reloj.

Marque el área con una pluma: Si el área está cerca de una incisión, use una pluma y rodee el área o dibuje una flecha que apunte al área preocupante antes de tomar una foto.

Use una regla: Corte la regla de la parte de atrás de este folleto y póngala sobre la piel junto a la herida.

Mantenga la cámara bien enfocada: Asegúrese de que su imagen sea clara. Si la imagen está borrosa, no podremos ver la herida. Debería poder ver los folículos pilosos o las arrugas de la piel en las fotos en primer plano.

Paso 1: Tome 3 fotos

Si tiene un área que le preocupa, deberá tomar al menos 3 fotos desde diferentes distancias. Use los ejemplos de abajo para cada foto que tome. Siga las instrucciones de la página siguiente para enviarlas a su equipo de atención.



Foto 1: Tome una foto de toda la extremidad o región de su cuerpo para que podamos ver dónde está la herida.

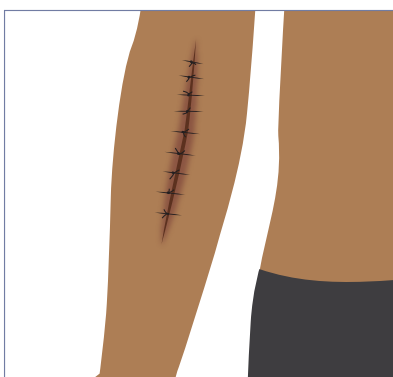


Foto 2: Tome una foto más cerca de la herida, incluyendo la herida y la piel que la rodea.

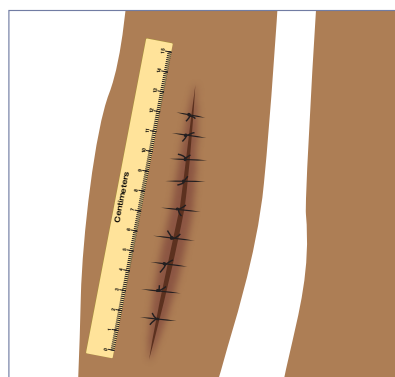


Foto 3: Ponga una regla en la piel junto a la herida. Tome una foto al menos a 8–12 pulgadas (20–30 centímetros) de su piel manteniendo la herida enfocada.

Paso 2: Envíe sus fotos a su equipo de atención

Después de tomar sus fotos, envíelas a su equipo de atención usando MyChart. Incluya la siguiente información en su mensaje:

Cuándo empezó el problema o la preocupación

Si hay algún drenaje o dolor en el lugar

Si hay alguna picazón en el lugar

Para ver un video sobre cómo adjuntar una foto a un mensaje de MyChart, escanee el código QR o visite **bit.ly/mychartvideo**. Si no usa MyChart, comuníquese con su equipo de atención para obtener una dirección de correo electrónico para enviar sus fotos. Si necesita enviar las fotos por correo electrónico, incluya también el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Tenga en cuenta que las imágenes enviadas fuera de MyChart no son seguras.



Código QR que enlaza al video de MyChart

Recursos

Centro de Recursos para Pacientes y Familias

Nuestro Patient and Family Resource Center (Centro de Recursos para Pacientes y Familias), en el tercer piso de Sloan Clinic 1, es un lugar acogedor donde puede pasar tiempo aprendiendo sobre un diagnóstico, tratamiento, apoyo y sobrevivencia específicos. Todo el material y los servicios son gratuitos.

El Centro de Recursos también tiene:

- Estaciones de trabajo con computadoras
- Servicios notariales con cita previa
- Una biblioteca en línea de libros electrónicos
- Información de conferencias, clases y grupos de apoyo en Seattle (no solo en los centros de Fred Hutch)

El personal del Centro de Recursos está disponible durante ciertas horas para dar apoyo y guía mientras busca material. Comuníquese con el personal en patientresourcectr@fredhutch.org o al (206) 606-2081, o en FredHutch.org/resource-center (o escanee el código QR abajo).

Información para el paciente

El equipo de atención le dará información específica para su situación médica. También puede encontrar videos de información para el paciente, folletos y otra información útil en FredHutch.org/patient-education (o escanear el código QR abajo).



Centro de recursos



Información para el paciente

Recursos para el cáncer de mama

Algunos de estos libros están disponibles en nuestra biblioteca digital. Solicite una tarjeta de la biblioteca aquí: FredHutch.org/digital-library



Biblioteca digital

Libros

- A Breast Cancer Alphabet, Madhulika Sikka
- Dr. Susan Love's Breast Book, Dr. Susan Love
- Breast Cancer: 50 Essential Things You Can Do, Greg Anderson
- Breast Cancer Journey: The Essential Guide to Treatment and Recovery, Ruth O'Regan
- The Mayo Clinic Breast Cancer Book, Lynn C. Hartmann and Charles L. Loprinzi
- The Breast Reconstruction Guidebook, 3rd Edition, Kathy Steligo
- Breast Cancer: The Complete Guide, Yashar Hirshaut and Peter I. Pressman
- Now What? A Patient's Guide to Recovery After Mastectomy, Amy Curran Baker
- The Language of Healing: Daily Comfort for Women Living with Breast Cancer, Pat Benson

Sitios web

- **National Comprehensive Cancer Network Guidelines (NCCN)** es una alianza sin fines de lucro de 28 de los principales centros oncológicos del mundo. Los expertos de NCCN redactaron directrices de tratamiento para los médicos que tratan el cáncer de mama. Estas directrices de tratamiento sugieren cuáles son las mejores prácticas para la atención del cáncer. La información en estos libros para pacientes está basada en las directrices escritas para los médicos.
nccn.org/patientresources/patient-resources/guidelines-for-patients
- **National Breast Cancer Foundation** tiene como objetivo salvar vidas aumentando la concienciación sobre el cáncer de mama por medio de la educación y aportando mamografías a quienes las necesitan. Los programas de NBCF dan a las mujeres ayuda para hoy y esperanza para mañana. nationalbreastcancer.org
- **Living Beyond Breast Cancer** da educación, programas y apoyo para ayudar a las personas cuyas vidas están afectadas por el cáncer de mama.
lbbc.org
- **Susan G. Komen Foundation** da educación, apoyo y ayuda económica a las personas afectadas por el cáncer de mama.
komen.org

- **Triple Negative Breast Cancer Foundation** es una fuente creíble y confiable de información sobre el cáncer de mama triplemente negativo, un catalizador para la ciencia y la defensa de los pacientes y una comunidad solidaria con servicios significativos para los pacientes y las familias. La fundación ofrece apoyo de subvención para la investigación, una línea de ayuda, programas de ayuda económica, foros de debate y material educativo.
tnbcfoundation.org
- **BreastCancer.org** es una organización sin fines de lucro dedicada a dar la información más confiable, completa y actualizada sobre el cáncer de mama. Su misión es ayudar a las mujeres y a sus seres queridos a entender la compleja información médica y personal sobre la salud y el cáncer de mama, para que puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas.
Breastcancer.org
- **Facing Our Risk of Cancer Empowered (FORCE)** da recursos y apoyo a las personas y familias afectadas por cánceres hereditarios de mama, ovario y otros relacionados.
facingourrisk.org/index.php
- **Bright Pink** ayuda a salvar vidas del cáncer de mama y de ovario empoderando a las mujeres para que conozcan el riesgo y cuiden su salud de manera proactiva.
brightpink.org/about-us/mission

Para obtener más recursos y grupos de apoyo, consulte nuestros Recursos sobre el cáncer de mama en FredHutch.org/breast-cancer-resources.



Fred Hutch Breast
Cancer Resources

MyChart

Mantenerse conectado
con la atención



En el portal de pacientes en línea de MyChart, puede:

- Ingresar al expediente médico
- Ver los resultados de las pruebas
- Ver y pedir citas
- Ver las listas de medicamentos, notas de proveedores, resúmenes después de la visita
- Enviar mensajes al proveedor
- Pedir resurtir recetas
- Pagar facturas en línea

Resultados de pruebas y mensajes

Los resultados de las pruebas se muestran en MyChart tan pronto como están disponibles, lo que significa que es probable que los vea antes que su proveedor. Los consultorios de los proveedores se comunicarán con usted si los resultados de las pruebas necesitan un cambio en la atención. Lea el folleto de la Ley de Curas para obtener más información.

MyChart es solo para mensajes no urgentes. Llame al equipo de atención para reportar síntomas o hacer preguntas concretas sobre la atención.



Escanee este código o visite
FredHutch.org/MyChart
para obtener más información sobre MyChart.

MyChart
UW Medicine

 **Fred Hutch**
Cancer Center

Camisolas, sostenes y prótesis para después de la mastectomía

Necesitará una receta para todas las prendas que usará después de la mastectomía, debe recibirla antes de la operación.

Llame para hacer una cita con un sastre de mastectomía certificado y revise la cobertura del seguro en cualquiera de las tiendas que se mencionan abajo antes de la operación.

- Recoja las camisolas antes de la operación.
- Espere 6 semanas después de la operación para que le ajusten los sostenes y las prótesis.

Shine

207 Pontius Ave N., Ste 101
Seattle, WA 98109
(206) 606-7560
Fax: (206) 606-7167
fredhutch.org/shine

Allies, una boutique especializada

1301 Fraser St. Ste A-101
Bellingham, WA 98229
(360) 676-7363
Fax: (360) 306-8297
alliesretail.com

A Better Fit

2417 W. Kennewick Ave, Ste A
Kennewick, WA 99336
(509) 628-4819
Fax: (509) 931-8889
abetterfit.info

Mary Catherine's

10002 Aurora Ave N.
Bldg 2, Suite 12
Seattle, WA 98133
(206) 322-1128
Fax: (206) 322-9239
marycatherines.com

Jim's Pharmacy/Home Health

424 E 2nd Street
Port Angeles, WA 98362
(360) 457-3462
Línea directa para ajustado:
(360) 504-2036
Fax: (360) 457-6557
jimsrx.com

Judy's Intimate Apparel

2528 Pacific Ave S.E.
Olympia, WA 98501
(360) 357-8807
Fax: (360) 956-9540
judysintimateapparel.com

Nordstrom/Bellevue

100 Bellevue Square
Bellevue, WA 98004
(425) 455-5800, x1240
Pregunte por el departamento de lencería

Nordstrom/Southcenter

100 Southcenter Mall
Tukwila, WA 98188
(206) 246-0400
Pregunte por el departamento de lencería

Nordstrom/Downtown

500 Pine Street
Seattle, WA 98101
(206) 628-2111
Pregunte por el departamento de lencería

The Essential Woman

507 S Sherman St.
Spokane, WA 99202
(509) 363-0100
Fax: (509) 363-6500
essentialwomanboutique.com

Lugares, direcciones y estacionamiento

UW Medical Center – Montlake

Dirección: 1959 N.E. Pacific Street, Seattle, WA 98195

UW Medical Center está en el extremo sur del campus de UW.

Indicaciones para llegar en auto

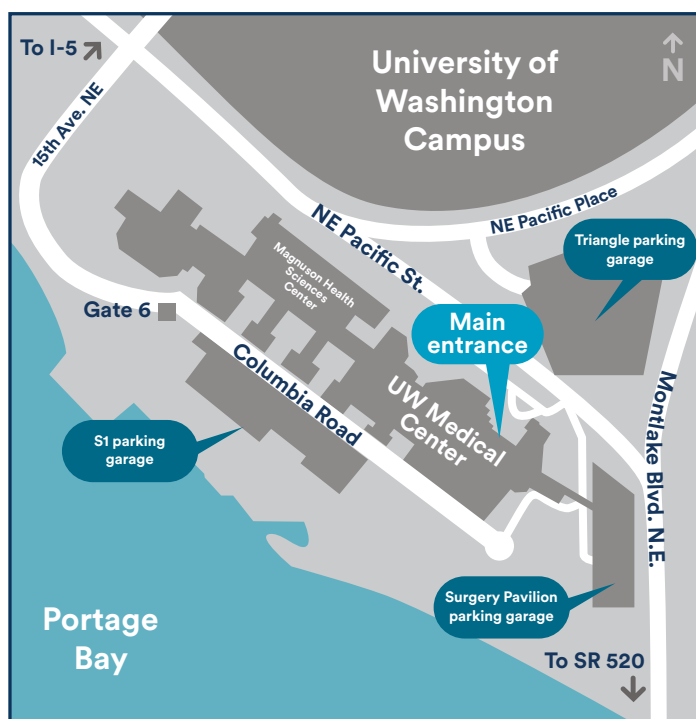
A **UW Medical Center – Montlake**, 1959 NE Pacific Street:

- **Desde la Interstate 5 (I-5):**

- Tome la salida 168B (Bellevue, State Route 520) en dirección este.
- Tome la salida Montlake Blvd.
- Siga las señales hacia University of Washington Medical Center.

- **Desde la Interstate 405 (I-405):**

- Tome la salida 14 (to Seattle via State Route 520) en dirección oeste.
- Tome la salida Montlake Blvd.
- Siga las señales hacia University of Washington Medical Center.



Estacionamiento

El estacionamiento está disponible en 2 lugares (vea el mapa):

- Triangle parking garage (“Estacionamiento para pacientes y visitas” (Patient Visitor Parking) en el mapa - subterráneo y al otro lado de N.E. Pacific Street desde el hospital)
- Surgery Pavilion parking garage (“Surgery Pavilion” en el mapa - en el extremo este del hospital)

UW Medical Center – Northwest

Dirección: 1550 N. 115th Street, Seattle, WA 98133

UW Medical Center – Northwest está situado en North Seattle, aproximadamente a 1 milla al noroeste de Northgate Mall.

Indicaciones para llegar en auto:

A **UW Medical Center – Northwest**, 1550 N. 115th Street:

• Desde la Interstate 5 (I-5):

- Tome la salida 173 y gire al oeste por Northgate Way.
- En Meridian Avenue North, gire a la derecha (norte).
- Tome la primera izquierda en 115th Street.
- La entrada principal del hospital estará a la derecha.
- Una vez que pase por la entrada principal, siga hacia adelante hasta el edificio principal de cinco pisos del hospital y gire a la derecha por debajo del puente aéreo. Pase la entrada de Urgencias a la izquierda y siga la calzada alrededor del hospital hasta llegar a la entrada norte de este. Hay un tótem cerca de la entrada.

Estacionamiento

Puede estacionarse en las áreas marcadas como “Surgery”. Entre por la entrada norte del hospital y camine en línea recta hasta el área de ingreso.



Notas

Lugares, direcciones y estacionamiento

Guía para la operación de mama

[illegible]

